

Auttava omainen

Tutkielma mielenterveysomaisille suunnatun uuden palvelun kehityshankkeesta

Matti Tahvanainen
Kulttuurintutkimus,
kulttuuriantropologia
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
Maaliskuu 2023

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
Kulttuurintutkimus / Kulttuuriantropologia
Tahvanainen, Matti: Auttava omainen - Tutkielma mielenterveysomaisille suunnatun uuden palvelun kehityshankkeesta
Opinnäytetutkielma, 70 sivua, 3 liitettä (8 sivua)
Tutkielman ohjaaja: Professori Tuulikki Kurki
Maaliskuu 2023

Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman kohteena on Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry:n yhteistyössä toteuttama mielenterveysomaisille suunnatun uuden palvelun kehityshanke. Hankkeen nimi oli Auttava omainen ja sen tarkoituksena oli parantaa omaisen yksilöllistä huomiointia psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoilla sekä tarjota vapaaehtoisen ja ammattilaisen työparina tarjoamaa neuvontaa ja vertaistukea ilman sairastuneen läheisen läsnäoloa. Tutkielma seuraa Auttava omainen -hankkeen suunnittelua ja toteutusta, joka kulminoituu pyrkimykseen muuttaa toimintakulttuuria psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoilla.

Tutkielman aineisto koostuu muistiinpanoista, haastatteluista ja Auttava omainen -hankkeen virallisista dokumenteista. Analyysi tapahtuu aineistolähtöisesti hyödyntäen grounded theoryn ja kategoria-analyysin periaatteita. Teoreettisessa viitekehyksessä suunnittelua lähestytään design-antropologisesta näkökulmasta. Lisäksi teoreettinen viitekehys käsittelee toimintakulttuuria ja kulttuuriantropologian suhdetta mielenterveyteen.

Analyysi etenee Auttava omainen -hankkeen alkuasetelman kautta tutkielman ydinasiaan, toimintakulttuurin muutokseen. Vapaaehtoisten puuttuessa Auttava omainen -hankkeen työryhmä keskittyy toimintakulttuurin muuttamiseen psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoilla. Toimintakulttuurin muutosta toteutetaan ensisijaisesti avaamalla omaisen kokemusta mielenterveyshoitajille. Tämä prosessi henkilöityy tutkielmassa suureen rooliin nousevaan Auttava omainen -hankkeen kehittämisasiantuntijaan, joka toimii arkityössään mielenterveyshoitajana. Omaisen asemaa havainnollistetaan analysoimalla psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa käytössä olevaa perhekeskeistä hoitotapaa.

Tutkielman tärkein tulos on aineistolähtöisesti muodostuva toimintakulttuurin muutosta käsittelevä teoria. Tutkielman perusteella toimintakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä, jonka motivoimiseksi tulisi luoda tunnepohjainen side. Tunnepohjaisen siteen luomiseksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon kontekstissa kokemusasiantuntijan tai mielenterveysomaisen kuunteleminen on tehokas keino. Toimintakulttuurin muuttamisessa esimiesten sitoutuminen ja aktiivinen panos sekä käytännön työssä että koulutuksessa on tärkeää, mutta kenties vielä merkityksellisempää voi olla ruohonjuuritason vapaaehtoinen työ.

Asiasanat: design-antropologia, grounded theory, kategoria-analyysi, kulttuuriantropologia, mielenterveysomainen, perhekeskeinen hoitotapa, toimintakulttuuri, tunneside

University of Eastern Finland, Philosophical Faculty
School of Humanities
Cultural studies / Cultural Anthropology
Tahvanainen, Matti: Helping caregiver – Thesis on a development project for a new service for mental health caregivers
Thesis, 70 pages, 3 appendixes (8 pages)
Supervisor: Professor Tuulikki Kurki
March 2023

Abstract:
This thesis examines a development project for a new service for mental health caregivers. The development project was called Helping caregiver (Auttava omainen) and it was a collaboration between Wellbeing services county of North Karelia – Siun sote and Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry, which is a regional association for mental health caregivers. The development project's purpose was to improve the individual attention given to caregivers at psychiatric wards and provide them a chance to get individual councelling and support from a mental health professional and a volunteer peer support worker without the presence of the mentally diseased. The thesis follows the planning and the execution of the development project.

The research material of the thesis consists of field notes, official documents and interviews. Analysis of the data was done using the principles of grounded theory and category analysis. Design anthropology, operational culture and cultural anthropology's relationship with mental illness are covered in the theoretical framework.

The analysis begins with the initial stages of the development project and ultimately focuses on the changing of the operational culture at psychiatric wards, which becomes the main objective of the project in the absence of peer support workers. The changing of the operational culture is done mainly by introducing mental health caregivers' experience to the nurses at the psychiatric wards. This process is personified by the development expert appointed by Siun sote. Caregiver's position in the mental health services is illustrated by analysing the family centered care principle.

The primary result of the thesis is a theory that illustrates the changing of the operational culture formed according to the principles of grounded theory. The theory suggests that a change in operational culture requires long-term commitment that should be motivated by an emotional bond. An efficient way to achieve emotional bond in the context of psychiatric care is to listen to an experience specialist or a mental health caregiver. The superiors' commitment and active participation in everyday practices and education is important but grassroots level volunteer work could be even more influential.

keywords: category analysis, cultural anthropology, design anthropology, emotional bond, family centered care, grounded theory, mental health caregiver, operational culture

Sisältö

1 Johdanto 1

1.1 Tutkielman tausta 1
1.2 Aiempi tutkimus 6
1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 7

2 Aineisto ja Menetelmät 9

2.1 Aineistolähtöinen teoria eli grounded theory 9
2.2 Kategoria-analyysi 14
2.3 Aineisto 15
2.4 Tutkimusetiikka ja tutkijan positio 18

2.4.1 Tutkimusetiikka 18
2.4.2 Tutkijan positio 20

3 Teoreettinen viitekehys 23

3.1 Suunnittelu ja toimintakulttuuri 23
3.2 Kulttuuriantropologia ja mielenterveys 27

4 Hankkeen alkuasetelma: neuvottelua tavoitteista ja aikataulusta 31

4.1 FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtajan odotukset ja tavoitteet 33
4.2 Kehittämisasiantuntijan odotukset ja yhteisymmärryksen luominen 35

5 Toimintakulttuuri nousee keskiöön 43

5.1 Auttava omainen -hanke muokkautuu vapaaehtoisten puuttuessa 44
5.2 Omaisen asema perhekeskeisessä hoitotavassa 46
5.3 Omaisen kokemuksen ymmärtäminen motivoi toimintakulttuurin muutosta 51
5.4 Auttava omainen -hankkeen arviointi 54

6 Tutkielman tulokset ja loppupohdinta 59
Lähteet 63
Liiteluettelo 70

1 Johdanto

1.1 Tutkielman tausta

Tutkimusaiheeni löytyi kandidaatintutkielmani (2017) yhteydessä syntyneiden henkilökontaktien avulla. Kandidaatintyöni käsitteli mielenterveysomaisten selviytymiskeinoja, joihin tutustuin mielenterveysomaisten kokemuksia koonneen kirjan pohjalta. Aiheen pariin johdatti oma kokemukseni kahden mielenterveyden häiriön kanssa elävän perheenjäsenen omaisena. Tutustuin FinFamin alueyhdistyksen henkilökuntaan aineistoa etsiessäni ja sain tietää tekeillä olevasta Auttava omainen -hankkeesta, jonka suunnittelu alkoi kesällä 2016. Auttava omainen -hankkeelle saatiin rahoitus noin kahdeksi vuodeksi alkaen vuoden 2017 tammikuusta. Tämä tutkielma keskittyy suunnitteluvaiheeseen ja toteuttamiseen, joten se ei sisällä jälkiseurantaa. Ensimmäinen pro gradu -tutkielmani aineiston keruuseen liittyvä toiminto oli kehityspalaveriin osallistuminen syksyllä 2017, ja aineiston keruu päättyi toukokuussa 2018 haastatteluihin. Tässä vaiheessa suurin osa Auttava omainen -hankkeen työstä oli tehty.

Tutkielman kohteena on Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry:n (viittaan järjestöön termillä FinFamin alueyhdistys) yhteistyössä toteuttama mielenterveysomaisille suunnatun uuden palvelun kehityshanke. Tutkielmassa käsitellään hankkeen suunnittelua ja toteutusta, joka kulminoituu pyrkimykseen muuttaa toimintakulttuuria psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoilla. FinFami eli mielenterveysomaisten keskusliitto on mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Suoritin opintoihini liittyvän työharjoittelujakson FinFamin alueyhdistyksessä, joten pääsin tutustumaan organisaation toimintaan läheltä. FinFamin alueyhdistyksellä on kolme vakituista työntekijää, joten kyseessä on Siun soteen verrattuna hyvin pieni toimija.

Kehitettävän palvelun nimi oli Auttava omainen ja sen ensisijainen tarkoitus oli antaa mielenterveysomaisille mahdollisuus puhua omasta voinnistaan ilman sairastuneen läheisen läsnäoloa ja

saada mielenterveyshoitajan ja vertaisomaisen työparina tarjoamaa neuvontaa ja tukea. Auttava omainen oli osa laajempaa AVOT (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) -hanketta (2016–2018). AVOT -hanke oli Pohjois-Karjalan osuus valtakunnallisesta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihankkeesta, josta liikeni rahoitus myös pienen mittakaavan Auttava omainen -hankkeelle.

Auttava omainen -hankkeen tavoitteita ja koulutusrunkoa on kuvattu liitteenä löytyvässä Auttava omainen -toimintamallissa. Toimintamallissa tavoitteet olivat seuraavat: perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa henkilökunta tunnistaa ja huomioi omaisen tuen tarpeen ja hyödyntää vertaistukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ohjaa omaisia tuen piiriin. Lisäksi päämääränä oli juurruttaa vertaistuellinen omaisneuvonta yhteistyötahoihin ja yhdistyksiin ja kouluttaa henkilökuntaa sekä omaisia vertaisten kanssa toteutettavaan työparityöskentelyyn. (ks. liite 1.)

Seurasin hankkeen kehitystä lähes alusta alkaen. Olin läsnä kehityspalavereissa, osallistuin erilaisiin koulutuksiin sekä suoritin työharjoittelun FinFamin alueyhdistyksessä. Auttava omainen -hankkeen kehittämän Auttava omainen -palvelun ytimessä on vertaistuellisen omaisneuvonnan malli, jossa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen ja vapaaehtoinen vertainen työskentelevät työparina. Pohjois-Karjalan versio palvelusta mukailtiin Varsinais-Suomessa kehitetystä alkuperäismallista paikalliseen toimintaan soveltuvaksi. Sosiaali- tai terveysalan ammattilainen toimii omaisneuvojana ja antaa tietoa mielenterveysongelmista ja hoidosta, kun vapaaehtoinen vertainen antaa samaan aikaan vertaistukea. Toissijainen tarkoitus oli parantaa sote-ammattilaisten valmiuksia omaisten huomiointiin. Mielenterveyspalveluissa omaisten huomiointi on pitkään ollut taka-alalla, joten Auttava omainen –hankkeen toteuttaminen loi uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa henkilökunnan päivittäiseen toimintaan ja rutiineihin. Uuden palvelun juurruttaminen mielenterveystyöhön on pohja, jolle on hyvä rakentaa pitkäkestoisiakin muutosprosesseja.

Varsinais-Suomen Auttava omainen -palvelusta on tehty kolme opinnäytetyötä. Mirka Impilä ja Sanna Pajunen (2018) käsittelivät opinnäytetyössään Auttava omainen -toiminnan juurtumista psykiatriseen hoitotyöhön hoitajien näkökulmasta. Heidän mukaansa Auttava omainen -toiminta

osastoilla oli omaisneuvontaa tekevien hoitajien varassa muun henkilökunnan tietämyksen toiminnasta ollessa varsin vaihtelevaa, joten suurimmaksi kehityskohteeksi nimetään tietämyksen lisääminen nimenomaan muun henkilökunnan keskuudessa. (Impilä & Pajunen 2018, 33–35.) Jussi Poikkimäki ja Janne Salminen (2014) selvittivät opinnäytetyössään Auttava omainen -palvelun yhteydessä suoritetun omaisneuvonnan vaikutusta omaisten hyvinvointiin. Omaiset kokivat omaisneuvonnan hyödylliseksi, mutta tiedottamisessa oli puutteita. (Poikkimäki & Salminen 2014, 32.) Anette Ojanen ja Lena Tölkkö (2016) puolestaan keskittyivät opinnäytetyössään vertaisneuvojan ja sote-ammattilaisen yhteistyöhön.

Mielenterveysomaisten selviytymiskeinoja käsitelleen kandidaatintutkielmani myötä opin mielenterveysongelmien olevan osa yhteiskunnan järjestystä niiden määritellessä omalta osaltaan hyväksyttävän käytöksen rajoja. Mielenterveysongelmiin liittyy niiden yleisyydestä huolimatta suuria ennakkoluuloja, joiden purkaminen kuuluu tutkimustyön haasteisiin. Omaisten kokemukset ja kohtelu terveydenhuollon yhteydessä ovat osa tätä aihepiiriä. On kaikkien etu, että omaiset kokevat tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi. Omaiset kokemuksineen toimivat välittäjinä psykiatrisen hoidon ja arkielämän välillä ja siten vaikuttavat yhteiskunnan kollektiivisiin mielikuviin.

Mielenterveysomaiset on ihmisryhmä, josta ei puhuta yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mielenterveysomaiset jäävät keskustelussa ikään kuin varjoon, kun keskitytään mielenterveyden ongelmiin, sairastuneisiin ja hoitokäytäntöihin. Kuitenkin mielenterveysomaisia on Suomessa merkittävä määrä, koska lähes jokaisella mielenterveyden häiriöön sairastuvalla ihmisellä on myös omaisia. Nämä omaiset kärsivät omalla tavallaan sen mukaan, millaisia valmiuksia heillä on käsitellä läheisen sairastumista. Mielenterveyden häiriöiden vakavuudessa on suuria vaihteluita, ja vakavat häiriöt voivat aiheuttaa merkittävää kärsimystä omaisille.

Tapasin Auttava omainen -hankkeeseen liittyvän koulutuksen yhteydessä henkilön, jonka puoliso sairastui skitsofreniaan hyvin nuorena eikä sairaus hellittänyt sen jälkeen. Kyseinen henkilö teki valinnan jäädä puolisonsa omaishoitajaksi ja pysyi hänen rinnallaan, kunnes puolison kuolema päätti tämän vuosikymmeniä kestäneen ajanjakson. Hän siis uhrasi oman työuransa, mahdolliset

perhehaaveet ja suuren osan ajastaan hoitaakseen sairastunutta puolisoaan. Silloin tällöin sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollistivat muutaman päivän loman omaishoitajan toimesta järjestämällä sijaisen hoitamaan puolisoa. Nyt jo elämänsä ehtoopuolella oleva henkilö ei katunut valintaansa vaan koki eläneensä arvokkaan elämän pysyttyään puolisonsa tukena.

Toisaalta vielä nyky-yhteiskunnassakin mielenterveyden häiriöön sairastunut saatetaan jättää oman onnensa nojaan. Syynä voi olla häpeä tai yksinkertaisesti sietokyvyn loppuminen. Mielenterveyden häiriön arvaamattomuus ja epätietoisuus sen ajallisesta kestosta lisäävät henkistä kuormitusta. Usein omaiset toivovat läheisen paranemista turhaan, tai hyvät ja huonot jaksot vuorottelevat. Mielenterveysomaisten kokemukset siis vaihtelevat valtavasti, joten yksilöllinen tarkastelu on ainoa mahdollisuus selvittää omaisen suhde sairastuneeseen ja sairastuneen aiheuttamiin ongelmiin. Mielenterveysomaisten kärsimys maksaa yhteiskunnalle määrittelemättömiä summia, mutta heitä ei juurikaan huomioida päätöksenteossa. Terveydenhuollossa on kyllä kehitetty keinoja omaisten huomiointiin, mutta parantamisen varaa löytyy vielä paljon.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on käytössä perhekeskeinen hoitotapa, jonka tarkoituksena on huomioida potilaan lisäksi koko perhe ja ottaa perhe mukaan hoitoprosessiin tukien näin sekä potilaan että perheen vointia. Tämän lähestymistavan keskiössä on hoitokokous, johon perheenjäsenet voivat osallistua. Hoitokokouksessa käsitellään potilaan vointia, ja omaiset voivat kysellä hoidosta ja tulevaisuudennäkymistä. Perhekeskeiseen hoitotapaan sisältyy teorian tasolla omaisten huomiointi, ja hoitajat kokevatkin huomioivansa omaisia toteuttaessaan perhekeskeistä hoitotapaa. Käytännössä omainen kuitenkin jää usein pelkän tiedonantajan rooliin, koska perhekeskeisessä hoitotavassa keskiössä on aina potilas eikä omaista huomioida yksilönä. Omaisen on myös hyvin hankala puhua potilaaseen ja omaan vointiinsa liittyvistä asioista avoimesti potilaan läsnä ollessa. Näin ollen perhekeskeistä hoitotapaa tulee tarkastella kriittisesti, kun tarkoituksena on parantaa omaisen yksilöllistä huomiointia.

Perhekeskeisyys on käsite, joka määrittelee hoitotyötä hyvin vahvasti. Oman kokemukseni perusteella omainen kohdataan tiedonantajana hyvin rutiininomaisesti. Omaiselle esitetään kysymyksiä liittyen potilaan toimintaan ennen hoitojaksoa ja tiedustellaan vaikutelmia potilaan voinnista.

Kun samaa toistetaan vierailukerrasta toiseen, muokkautuvat myös omaisen odotukset vierailuista vastaamaan tätä käytäntöä. Omaisen kohtaaminen ihmisenä vaatii siis perustavanlaatuista toimintakulttuurin muutosta ja rutiinien murtamista.

Tämän tehtävän ytimessä on se, miten omainen käsitetään eri yhteyksissä. Tutkielmani näyttää kaksi erilaista tapaa nähdä omainen: ihmisenä ja tiedonantajana. Järjestötyön omaisen ongelmiin keskittynyt ihmisen kokonaisuutena huomioiva näkökulma ja omaisen kohtaaminen tiedonantajana terveydenhuollossa tuovat tutkielmaan kontrastin, joka on sekä palvelun suunnittelussa että tutkielmassani keskeinen tekijä sen tuodessa ilmi omaisen kohteluun liittyviä epäkohtia. Tutkielmani valaisee mielenterveysomaiseen liittyviä käsityksiä analysoimalla tämän kontrastin esiin tuomia merkityksiä Auttava omainen -hankkeen kehityksen yhteydessä. Mielenterveysomaiseen liittyvät käsitykset ovat keskeisessä asemassa tutkielmani keskiöön nousevassa pyrkimyksessä muuttaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintakulttuuria. Anna Kinnunen (2020) kuvaa tutkijan astuvan ”kulttuuristen merkitysten maailmaan” silloin, kun tämä tulkitsee havaittujen käsitysten syntymistä ja muihin käsityksiin punoutumista. Kinnusen mukaan ”merkitysten tutkiminen onkin ajattelua ja toimintaa ohjaavien, piiloisten ja usein myös pitkäkestoisten kulttuuristen jäsennysten hahmottamista.” (Kinnunen 2020, 49.)

Läheisen sairastuminen heijastuu mielenterveysomaisen elämään mielenterveyden häiriöihin liitettyjen käsitysten suodattamana. Läheisen sairastumisen myötä omaisen täytyy arvioida omaa identiteettiään ja elämäntilannettaan uudelleen, kun hän joutuu kohtaamaan mielenterveyden ongelmiin liitetyt ennakkoluulot ja käsitykset. Tämän prosessin vaikutukset ovat arvaamattomia ja hyvin tapauskohtaisia. Omaisen täytyy löytää oma tapansa käsitellä läheisen sairastumista ja pohtia kuinka avoimesti sairastumisesta puhutaan. Toisinaan sairastuneen omaiset pelkäävät sairastumisen leimaavan koko perheen ja he salailevat tapahtunutta. Jos sairastumisesta puhutaan avoimesti, arvaamattomuuteen tuo oman lisänsä ulkomaailman reaktioiden vaikutus. Sairastuneen perheenjäsenet voivat suhtautua sairastumiseen eri tavoin, mikä voi aiheuttaa jännitteitä. Perhedynamiikka muuttuu joka tapauksessa, kun perhe sopeutuu sairastumiseen.

Kirsi Juhilan (2012) mukaan sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa toisen ryhmän jäsenten homogeenistavaa ulkoryhmäkategorisaatiota kutsutaan poikkeavuudeksi. Poikkeavuutta tuotetaan esimerkiksi tuomitsemalla itsen ulkopuolisen ryhmän jäsenten käyttäytyminen vääräksi ja ei-hyväksyttäväksi. Poikkeavien kategorisaatio toteutuu toiminnassa eikä ole siten pysyvä ihmisryhmään liitetty määre, vaan se on mahdollista joko uusintaa tai kyseenalaistaa. Mielisairaan ja mielisairauden kategoriat ovat kulttuuriseen tietoon nojaavia stereotypisoivia kategorioita. (Juhila 2012, 190–191.) Läheisen sairastuessa poikkeavuuden kokemus tulee lähelle omaista mielenterveyden ongelmiin liitettyjen kategorioiden kautta. Usein perheenjäsenen sairastuminen leimaa koko perheen, jolloin poikkeavuuden kokemus koskee omaisiakin. Kuitenkaan ei ole olemassa selvää mielenterveysomaisen kategoriaa ja siihen liittyviä odotuksia, joiden avulla omaa uutta elämäntilannetta voisi jäsentää suhteessa yhteiskuntaan. Jos terveydenhuolto kategorisoi omaisen tiedonantajaksi, joutuu omainen etsimään omiin ongelmiinsa ratkaisua muualta, mikä tarkoittaa usein yksin jäämistä.

1.2 Aiempi tutkimus

Mielenterveysomaisista on tehty hyvin vähän tutkimusta, johon tätä tutkielmaa voisi verrata. Mielenterveysomaisiin liittyvää tutkimusta, jossa kuvataan omaisten kokemusta ja suhdetta terveydenhuoltoon on jonkin verran. Suomessa omaisten olosuhteita on tutkinut esimerkiksi Eija Stengård (2005) väitöskirjassaan, jossa hän kuvaa skitsofreniapotilaiden omaisten kokemuksia ja tarpeita. Stengård on yhdessä Markku Nymanin (2001, 2005) kanssa valottanut omaisten hyvinvointiin liittyviä seikkoja laajemmin.

Vertaistoiminnasta terveydenhuollossa on paljon artikkeleita, koska vertaistoiminnan hyödyntäminen on saamassa jalansijaa yhä enemmän. Myös mielenterveyspalveluiden yhteydessä tapahtuvaan vertaistoimintaan liittyvää tutkimusta löytyy, mutta se koskee lähinnä sairastuneiden tukemista. Foster, Gibson, Gillard, Goldsmith, Marks & White (2017) ovat arvioineet vertaistuen juurruttamista mielenterveyspalveluihin. He painottavat jatkuvan reflektiivisen oppimisen ja arvioinnin tärkeyttä uuden toimintamallin jatkuvuudelle ja pitävät tiukkojen sääntöjen laatimista ver-

taistukitoiminnalle vahingollisena. (Foster ym. 2017, 140–141.) Lisää terveydenhuollossa tapahtuvasta vertaistoiminnasta ja sen esteistä: katso esimerkiksi Carter & Repper (2011), Basset & Faulkner (2012), Doughty & Scott (2012) ja Edwards, Gillard, Gibson, Owen & Wright (2013).

Barrett, Gibson, Gillard & Oborn (2019) ja Chester, Crompton, Ehrlich, Slattery & Vidic (2020) ovat tutkineet vertaistyöntekijän liittymistä mielenterveyspalveluja tuottaviin työryhmiin. Heidän mukaansa vertaistyöntekijän vaikutus näkyy erityisesti kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa, kun vertaistyöntekijä avaa uusia kommunikoinnin väyliä. Vertaistyöntekijän hyväksyminen työryhmän jäseneksi edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta keskittymistä vertaistyöntekijän vahvuuksiin ja oman näkökulman muokkaamista siten, että vertaistyöntekijää ei nähdä hänen diagnoosinsa välityksellä. Vertaistyöntekijän kokemusperäinen tieto täydentää hoitohenkilökunnan ymmärrystä hoidosta. (Barrett ym. 2019, 1319; Chester ym. 2020, 113.)

Bochicchion, Cabassan, Collins-Andersonin, Stefancicin & Tudan (2022) mukaan vertaistoiminnan sisällyttäminen organisaation toimintaan vaatii tiukkaa valvontaa ja koko henkilökunnan kouluttamista otollisen työilmapiirin luomiseksi. Vertaistoiminnan jatkuvuus edellyttää asian sisäistämistä organisaation kaikilla tasoilla johtajista henkilökuntaan. (Bochiccio ym. 2022.) Myös Jones, Rosen, Teague & Wolf (2020) painottavat rakenteellisen muutoksen tärkeyttä vertaistoiminnan sisällyttämiseksi mielenterveyspalveluihin. He uskovat vertaistoiminnan olevan tärkeä työkalu mielenterveyspalvelujen kulttuurin parantamisessa ja vaativan organisaatioilta arvojen, kulttuurin ja tehokkaiden muutosstrategioiden tarkastelua. (Jones ym. 2020, 163.)

1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tutkimustehtävä on selvittää Auttava omainen -hankkeen myötä paljastuvia omaisen paremman huomioinnin kannalta olennaisia muutostarpeita psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintakulttuurissa. Lisäksi tehtävänä on selvittää Auttava omainen -hankkeen kehityskaaren eri vaiheissa ilmeneviä odotuksia, esteitä ja mahdollisuuksia, joita sisältyy toimintakulttuurin muutoksen toteuttamiseen. Tutkielman keskiöön nousee aineiston perusteella mielenterveyshoitajien suhtautuminen toimintakulttuurin muutokseen, ja erityisesti tämän suhtautumisen muutos omaisten

kokemuksiin tutustumisen jälkeen. FinFamin alueyhdistyksellä on tärkeä rooli omaisen kokemuksen välittämisessä. Tämä kehityskaari henkilöityy vahvasti työryhmää johtaneeseen mielenterveyshoitotyötä tehneeseen kehittämisasiantuntijaan. Tutkimuskysymykset tarkentuivat aineiston analyysin yhteydessä ydinasioiden paljastuessa aineistolähtöisesti.

Pääkysymys:

Miten Auttava omainen -hankkeen suunnittelu -ja kehitystyön yhteydessä avautuva omaisen näkökulma vaikuttaa toimintakulttuurin muutokseen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, ja mitä esteitä toimintakulttuurin muutokselle paljastuu?

Alakysymykset:

Miten suunnittelutyöryhmä luo yhteisymmärryksen ja omat työtavat erilaisista odotuksista, taustoista ja asenteista huolimatta?

Miten omaisen kategorisointi perhekeskeisessä hoitotavassa muuttuu, kun omaisen yksilöllistä huomiointia pyritään parantamaan?

2 Aineisto ja Menetelmät

2.1 Aineistolähtöinen teoria eli grounded theory

Teoreettisten tulkintojen muodostaminen todellisuuteen pohjautuvasta aineistosta antaa mahdollisuuden sekä ymmärtää maailmaa että kehittää toimintastrategioita, joiden kautta voidaan jossain määrin hallita toimintaympäristöä. (Corbin & Strauss, 1990, 9.) Tämä periaate tiivistää hyvin tavoitteeni tutkielmani suhteen. Haluan ymmärtää aineistoani ja sen pohjana olevaa projektia sekä tuottaa siitä jäsennetyn aineistoon pohjautuvan analyysin, jolla on todellisuuteen sovellettavissa olevat johtopäätökset.

Pro gradu -tutkielmani kohde valikoitui aikaisempien opintojen ja elämänkokemuksen perusteella, joten ennakko-oletuksia ja kirjallisuuteen tutustumista oli tietenkin taustalla. Luotin koulutukseeni heittäytyessäni tutkielman tekoon ja seurasin vaistoani. En kuitenkaan osannut vielä aineistoa kerätessäni ajatella asiaa grounded theoryn pohjalta, joskin toimintatapani soveltuivat hyvin tähän metodiin. Näin ollen grounded theory valikoitui luonnollisena vaihtoehtona tutkielman päämetodiksi. Grounded theoryn suomenkielisiä nimiä ovat aineistolähtöinen teoria ja ankkuroitu teoria, mutta olen pitänyt englanninkielisen muodon, koska suomalaiset vastineet eivät ole laajasti käytössä ja voivat aiheuttaa sekaannusta.

Bryantin (2017) mukaan grounded theoryn metodit olivat hyvin innovatiivisia ja haastavia tutkimusyhteisölle, kun ne 60-luvulla syntyivät. Nykyään grounded theory on laajalti hyväksytty tutkimustapa. Erityisesti tiedemaailmassa korostunut metodien tärkeys toimi käynnistäjänä grounded theoryn nousulle. Grounded theory oli aikanaan kehittäjiensä Glaserin ja Straussin ratkaisu vallitsevan akateemisen hierarkian horjuttamiseen. He halusivat vaihtoehdon perinteiselle hypoteesiperusteiselle tutkimukselle. Grounded theory mahdollistaakin tutkijan hyppäämisen tutkimuksen pariin ilman valtavaa teoreettista taustatyötä. Strauss ja etenkin Glaser kannustivat aloittamaan tutkimuksen jopa ilman ennakkokäsityksiä tutkittavasta asiasta, mikä tietenkin on mahdotonta. Näin ollen tutkijan kannattaa joka tapauksessa käydä tarkkaan läpi omat oletuk-

sensa tutkittavasta asiasta eikä yrittääkään sivuuttaa niitä. Kirjallisuuteen perehtymisen jättämisessä tutkimuksen loppuvaiheisiin piilee se vaara, että oma tutkimus ei olekaan niin ainutlaatuinen kuin alun perin luultiin. Perinteisesti grounded theorya kannustettiin käyttämään aiheisiin, joista ei juurikaan ole tutkimusta. Tutkimuksen lukija tulisi siinä tapauksessa vakuuttaa aikaisemman tutkimuksen puuttumisesta, mutta se ei nykyisen tietomäärän ja internetin maailmassa ole järkevä lähtökohta. Näin ollen grounded theory on liikkumassa siihen suuntaan, että oman tutkimuksen kohteesta tehdään alustava kirjallisuuskatsaus yllätyksien välttämiseksi. Avain on tasapainon löytäminen systemaattisen ja epäsystemaattisen lähestymistavan välillä. Etenkin aloittelevien tutkijoiden ongelmana on usein oppikirjojen liian tarkka seuraaminen, jolloin tutkimuksen monitahoisuutta joko vältetään tai jopa ei käsitellä lainkaan. (Bryant 2017, 13, 21–26, 91.)

Ian Deyn (2007) mukaan grounded theoryn tarkoitus on tuottaa teoria aineistolähtöisesti sen sijaan, että tutkimus perustuu ennen aineiston keruuta kehiteltyyn teoreettiseen ideaan. Tutkijalla on siis oltava kyky tuottaa ideat aineistosta käsin ilman ennakkokäsityksiä. Tämä lähtökohta vaikuttaa myös aineiston keräämiseen, koska tutkimuksen edistyminen ohjaa tutkijaa uusien kysymysten äärelle ja siten keräämään aineistoa tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Grounded theory nojaa ensisijaisesti laadulliseen aineistoon, mutta ei sulje pois määrällistäkään vaihtoehtoa. Aineiston analyysia ohjaa koodaaminen eli katkelmien ja teemojen ryhmittely, jonka avulla pyritään muodostamaan kategorioita vertailua varten. Kategorioiden tulee olla analyyttisiä ja herkistää tutkijaa tekemään merkityksellisiä tulkintoja aineistosta. Ajatuksena on kehittää tutkimuksen käsitteitä vertailemalla sen osia jatkuvasti työn eri vaiheissa. Vertailua tulisi tehdä väittämien, löytöjen, tapahtumien luonnehdintojen ja koodien välillä. Tämä jatkuva vuorovaikutus aineiston ja analyysin välillä auttaa huomaamaan yhdenmukaisuuksia ja korkeamman tason abstraktioita. Näiden abstraktioiden muodostamat kuviot ja mallit voidaan luokitella kategorioiksi, joihin yhdistetään toisiinsa liittyviä tapahtumia, esimerkkejä jne. Aineistoa kerätään niin kauan, kunnes saavutetaan riittävä saturaatio eikä tarvetta lisäaineistolle enää ole. Aineisto ohjaa analyysia, ja analyysi voidaan lopettaa, kun ydinkategoria ja sen pääteemat ovat löytyneet. (Bryant 2017, 96; Dey 2007, 80–81.)

Omaa aineistonkeruutani johdatti Auttava omainen -hankkeen kehitys. Alkuun olin mukana kehityspalavereissa, myöhemmin koulutuksissa ja lopulta haastattelin keskeisiä toimijoita. Seurasin siis eräänlaista polkua, jossa yhden etapin jälkeen seuraavalle ohjasi hanke itse hyvin luonnollisella tavalla. Analyysin aloitin etsimällä aineistosta teemoja, joista kehitin analyyttisia kategorioita jatkuvasti vertailemalla niitä aineistoon ja toisiinsa. Lopulta pyrin kategorioiden avulla vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja kehittämään aineistolähtöisen teorian. Analyysin edetessä perehdyin kirjallisuuteen tutkielman viitoittaessa tässäkin suhteessa tietä. Koen, että aineisto oli kattava tämän tutkielman tarkoitukseen nähden, koska haastatteluissa esiintyi pienestä määrästä huolimatta saturaatiota, ja pystyin hyvin vastaamaan tutkimuskysymyksiin aineiston pohjalta.

Avainkategorioiksi nousivat Auttava omainen -hankkeen alkuasetelman osalta työryhmän jäsenten odotukset, asenteet ja aiempi kokemus hanketyöstä. Näiden kategorioiden kautta pyrin hahmottelemaan yhteisymmärryksen syntymistä ja yhteisen aikajanan hakemista. Yhteisymmärrys ja yhteinen aikajana mahdollistavat tehokkaan suunnittelun toimimalla perustana realistisille tavoitteille. Koin alkuasetelman analysoinnin tärkeäksi myös sen takia, että se toimii vertailupohjana myöhemmin tapahtuville muutoksille työryhmän tavoitteissa ja motivaatiossa muuttaa toimintakulttuuria.

Tämän tutkielman tärkeimmäksi kategoriaksi nousee toimintakulttuurin muutos, jota käsitellään viidennessä luvussa. Toimintakulttuurin muutosta tukevia alakategorioita ovat tunnepohjainen reaktio, motivaatio, osallistaminen, tiedonvälitys, toimijuus, omaisen kokemus ja kokemusasiantuntijuus. Muutosta estäviä kategorioita ovat työpaikan rutiinit, perhekeskeisen hoidon käytännöt, esimiesten välinpitämättömyys ja puutteellinen käsitys omaisen kokemuksesta. Toimintakulttuurin muutoksen analysointi johtaa grounded theoryyn pohjautuvan teorian muodostumiseen.

Kathy Charmaz on kehittänyt grounded theorya konstruktivistiseen suuntaan. Artikkelissaan *The Power of Constructivist Grounded Theory for Critical Inquiry* (2017) Charmaz toteaa konstruktivistisen grounded theoryn perustuvan pragmaattiseen filosofiaan. Pragmatismin ja kon-

struktivistisen grounded theoryn keskiössä on todellisuuden näkeminen sosiaalisena ja prosessuaalisena eli sosiaalisten rakenteiden oletetaan perustuvan ihmisten toiminnan kautta ilmentyville prosesseille. Pragmatismin avulla voidaan päästä käsiksi implisiittisiin toimintoihin ja prosesseihin, jotka normaalisti jäävät huomaamatta. Konstruktivistinen grounded theory on metodi, joka tuottaa näistä toiminnoista ja prosesseista käsitteitä analysoitavaksi. Perustana toimii metodologisen itsetietoisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen tutkimuksen kestäessä, mikä puolestaan vaatii tutkijalta refleksiivisyyttä. Metodologinen itsetietoisuus tarkoittaa maailmankuvan, kielen ja tarkoitusten huomioimista ja purkamista tutkimuksen kontekstissa siten, että tutkija tutkii myös itseään tutkimusprosessin aikana. Tähän kuuluu myös voimasuhteiden, identiteetin ja subjektiivisuuden määrittely sekä tutkijan että tutkittavien osalta. Konstruktivistinen grounded theory mahdollistaa itsestäänselvyyksinä otettujen asioiden haastamisen ja ennen kaikkea tutkijan oman position tarkastelun suhteessa tutkimuskohteeseen. Metodologisen itsetietoisuuden kehittäminen antaa tutkijalle keinoja huomata millä tavoin ja missä määrin tämän omat henkilökohtaiset mielipiteet ja näkemykset vaikuttavat tutkimuksen tekoon ja analyysiin. (Charmaz, 2017.)

Corbin ja Strauss (1990) pitävät luovuutta elintärkeänä osana grounded theoryyn perustuvaa metodia. Se pakottaa tutkijan rikkomaan oletuksia ja näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Tutkijan luovuus tulee näkyviin tämän kyvyssä nimetä kategorioita ja muodostaa vapaan assosioinnin keinoin tutkimusta hyödyttäviä kysymyksiä sekä löytöihin johtavia vertailuja. Vertailut herkistävät tutkijaa tunnistamaan mahdolliset kategoriat ja identifioimaan tapahtumien edellytykset ja seuraukset aineistosta. Nimenomaan luovuus antaa tutkijalle mahdollisuuden esittää relevantteja kysymyksiä aineistosta ja johtaa siitä uusia oivalluksia ja teorioita. (Corbin & Strauss 1990, 27–31.)

Bryant (2017) sanoo tutkijan siirtyvän abstrahoinnin myötä havainnoista, muistiinpanoista ym. lähteistään kehittyneemmälle ja keskittyneemmälle tasolle. Tämä on sekä kognitiivinen että metodologinen prosessi ja sen myötä tutkimuksen osista löydetään oleellisimmat. Tutkijan ei siis pidä olettaa, että aineisto antaa vastaukset itsestään. Aineistoon on suhtauduttava avoimin mielin ja annettava näin mahdollisuus sattumalle ja yllätyksille. Aina on mahdollisuus, että aineisto

johdattaa täysin eri urille kuin ensin on ajateltu. Haastatteluihin täytyy suhtautua terveen skeptisesti, että päästään käsiksi haastateltavien kuvaamien ilmiöiden taustaprosesseihin. Näistä sosiaalisista prosesseista rakennettu malli toimii tutkimuksen runkona. Toisin sanoen tutkijan tulisi saada selville mitä tutkittavat tarkoittavat sanomisillaan ja toisaalta myös huomioida mitä he mahdollisesti jättävät sanomatta. (Bryant 2017, 162–164.)

Corbin ja Strauss (1990) sanovat muistioiden toimivan tärkeänä työkaluna grounded theoryn tekemisessä. Tutkimuksen kontekstissa muistio tarkoittaa asiakirjaa, johon kirjataan ylös analyysin tuloksia eli käytännössä ne ovat tutkijan aineistosta johtama abstrakti ajattelu kirjallisessa muodossa. Muistio voi sisältää muistiinpanoja koodeista, teoreettista ajattelua tai tutkimuksen toimenpiteisiin liittyvää pohdintaa. Muistioiden on tarkoitus kehittyä tutkimuksen kestäessä. Niistä tulee monitahoisempia, tiiviimpiä, selkeämpiä ja tarkempia. Muistioiden myötä tutkija ottaa analyyttistä etäisyyttä aineistoon, mikä auttaa siirtymään abstraktiin ajatteluun. Muistioiden avulla tutkijan abstraktiot saadaan yhdistettyä todellisuuteen vertaamalla niitä aineistoon. Lopulta muistiot toimivat tutkimuksen analyysiosion pohjana eli muistioista tulee eräänlainen tutkijan tietopankki. (Corbin & Strauss 1990, 198–199.)

Bryantin (2017) mukaan aineisto on avoinna monille erilaisille tulkinnoille tutkimuksen eri vaiheissa, joten tutkijan on tehtävä valintoja tutkimuksen suunnan suhteen jatkuvasti. Näin ollen jo koodaus ja koodien kategorisointi voidaan nähdä alustavien hypoteettisten lausumien tekemisenä, koska niistä johdetaan aineistoa kuvaavat abstraktiot. Tässä tulee ilmi myös tutkimusprosessin konstruktiivisuus, koska eri tutkijat tuottavat samasta aineistosta lähes varmuudella erilaisia koodeja. Tutkimustulokset siis riippuvat osaltaan tutkijan kyvystä abduktiiviseen päättelyyn eli kyvystä löytää paras selitys. Abduktiivinen päättely on grounded theoryn kannalta olennaista, koska sen avulla vältetään induktion heikkoudet eikä kaikkia aineistosta johdettavissa olevia hypoteeseja pidetä samanarvoisina, joten tutkija pystyy valitsemaan tutkimuksen kannalta toimivimman hypoteesin ja jatkamaan sen pohjalta. Grounded theoryn päämääränä on luoda teoria, jolla on käyttöarvoa. Teorian ei ole tarkoitus olla spekulatiivinen eikä myöskään universaali selitys mihinkään ongelmaan. Sen sijaan tutkija yrittää kehittää oman teoriansa, joka perustuu kes-

keisiin aineistosta johdettuihin konsepteihin. Tärkeintä on siis teorian toimivuus ja sen johtaminen aineistosta. Mahdollinen laajempi sovellettavuus selvitetään myöhemmin. Uudet teoreettiset oivallukset arvioidaan joka tapauksessa sen perusteella, että muuttavatko ne ihmisten käytännöllistä ymmärrystä tai toimintatapoja. (Bryant 2017, 277–278, 343.)

Omassa tutkielmassani grounded theoryn pohjalta nouseva teoria perustuu hyvin selkeästi abduktiiviseen päättelyyn. Alkuasetelman hahmottelun kautta edetään kronologisesti suunnittelun tapahtumia analysoiden teorianmuodostukseen. Aineisto paljastaa keskeiset konseptit, joista teoria rakennetaan hyödyntäen grounded theoryn periaatteita.

2.2 Kategoria-analyysi

Hyödynnän kategoria-analyysin elementtejä eritellessäni omaisen saamia merkityksiä eri konteksteissa. Omaisen näkeminen tiedonantajana tai kokonaisvaltaisena ihmisenä ovat avainkategorioita tutkielmassani. Näiden kategorioiden vertailu on keskeinen tekijä perhekeskeisen hoitotavan analyysissä ja siten myös lopullisen teorian muodostumisessa. Tiedonantajan ja kokonaisvaltaisen ihmisen kategoriat kulkevat läpi tutkielman jäsentäen omalta osaltaan kokonaisuutta.

Jokisen, Juhilan & Suonisen (2010) mukaan ihmiset voivat valita mitä kategorioita he ottavat käyttöön toisia ihmisiä kohdatessaan. Kategoriat heräävät eloon näissä kohtaamisissa, joten ne todellistuvat paikallisesti. Näin ollen kategoria-analyysissä ollaan kiinnostuneita siitä, millaisia kulttuurisesti jaettuja merkityksiä ja tunnuspiirteitä kohtaamisissa on havaittavissa. Lisäksi voidaan tarkastella muita tilanteeseen mahdollisesti soveltuvia, käyttämättä jääneitä kategorisointeja. (Jokinen ym. 2010, 19–20.) Orientoituminen vuorovaikutustilanteeseen siihen liitettyjen piirteiden pohjalta mahdollistaa johdonmukaisen toiminnan (Zimmerman 2008, 105).

Psathas (1999) kuvaa organisaatioissa tapahtuvaa kategorisointia prosessiksi, jota toimijat tuottavat kanssakäymisessä. Rooleissaan toimiessaan osapuolet osaavat hyväksyä ja vahvistaa toistensa näkemykset omista kategorioistaan ja siten toimia yhteisymmärryksessä. Toiminta on siis paitsi riippuvaista kategorioista myös kategorioita rakentavaa. (Psathas 1999, 156.) Jokinen

(2010) kertoo instituutioiden antavan vahvan legitimiteetin ammatillisesti tuotetuille kategorioille ja niiden välityksellä toiminnoille. Kategoriat toimivat institutionaalisten rutiinien perustana ja liittyvät arkisiin työkäytäntöihin. Kategorioiden ja instituutioiden sosiaalinen ja moraalinen järjestys tuotetaan institutionaalisiin identiteettikategorioihin ja toimija-asemiin sidotussa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. (Jokinen 2010, 265–266.)

Tutkielmani kannalta on olennaista se, miten kapea tiedonantajan kategoria laajentuu omaisen kokemuksen avautuessa. Koska tiedonantajan kategoriaa rakennetaan ja vahvistetaan arkisilla työkäytännöillä, on sen laajentamiseksi muutettava näitä työkäytäntöjä. Tutkielmani havainnollistaa, miten auttava omainen -hankkeen myötä syntyvät omaisen parempaan huomiointiin tähtäävät prosessit pyrkivät vaikuttamaan työkäytäntöihin monella eri tasolla.

2.3 Aineisto

Aineistoni koostuu Auttava omainen -hankkeen virallisista suunnittelu- ja koulutusmateriaaleista, omista muistiinpanoistani, arviointikeskusteluista sekä haastatteluista. Suunnittelu- ja koulutusmateriaalit ja arviointikeskustelut ovat osittain Siun soten ja osittain FinFamin alueyhdistyksen laatimia ja niitä on erilaisissa muodoissa noin 20 sivua. Muistiinpanoja on kuudesta palaverista ja kolmesta koulutuksesta, yhteensä kahdeksan sivua. Haastatteluja on kolme kappaletta, määrältään 33 sivua litteroitua tekstiä.

Aineiston keruun alkuvaiheissa harkitsin etnografian koostamista, mutta palavereja ja koulutuksia oli sen verran harvassa, että siihen niistä ei riittänyt aineksia. Arjessa tehtävään työhön minulla ei ollut pääsyä. Palaverien tarkoitus oli koota toimijat yhteen ja päivittää hankkeen tilanne sekä suunnitella jatkoa. Koulutuksia oli sekä vertaisille että terveydenhuollon henkilökunnalle tavoitteenaan mahdollistaa Auttava omainen -mallin mukainen työparityöskentely. Auttava omainen –hanke on osa 30-vuotista jatkumoa, johon sisältyy kolmannen sektorin kamppailu vakavasti otettavaksi yhteistyökumppaniksi erikoissairaanhoidolle. Kehitys on ollut hidasta, mutta Auttava omainen -hanke toimii esimerkkinä mahdollisuudesta saada aikaan jopa pysyvä rakenteellinen muutos, jossa järjestö pääsee aktiiviseksi osaksi erikoissairaanhoidon toimintaa.

Näin ollen aineistoni tärkeimmäksi osa-alueeksi muodostuvat keskeisten toimijoiden haastattelut, joita on kolme kappaletta. Haastattelujen määrä on pieni johtuen tutkittavan Auttava omainen -hankkeen pienimuotoisuudesta. Graduuni liittyvät haastattelut toteutettiin FinFamin Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen tiloissa harjoitteluni jälkeen, toukokuussa 2018. FinFamin alueyhdistys työllistää kolme ihmistä, joista kaksi oli mukana Auttava omainen -hankkeessa. Näistä kahdesta haastateltavaksi valikoitui toiminnanjohtaja, joka oli keskeinen hahmo etenkin suunnittelun alkuvaiheessa. Siun soten puolelta Auttavaan omaiseen saatiin päätoimisesti vain yksi henkilö, joten hänenkin valintansa haastateltavaksi oli selviö. Lisäksi haastattelin Siun soten rahoittamaa hanketyöntekijää, joka toimi sekä Siun soten että FinFamin alueyhdistyksen kanssa ja oli tärkeä tekijä projektin osa-alueiden suunnittelussa ja koostamisessa.

Koostin kysymykset itse harjoittelun aikana perustuen omaan osallistumiseeni Auttava omainen –hankkeen eri vaiheisiin ja osioihin kuten palavereihin ja koulutuksiin. Kaikkiaan koen omaavani melko kattavan kuvan projektin eri vaiheista, joskin aivan alussa en ollut mukana. Sain kuitenkin alkuvaiheistakin tietoa mm. projektin kuvauksen ja sähköpostiketjujen muodossa. Haastattelut ovat hyvin yleinen menetelmä kaikenlaisten tutkimusten teossa, mutta ihmistieteiden osalta niiden merkitys korostuu. Itselleni haastattelurungon laatimisessa haastavinta oli riittävän kattavuuden luominen, mikä vaatikin runsaasti aikaa eikä koskaan tuntunut tyydyttävältä. Haastattelujen alkaessa oli vain luotettava haastattelurunkoon, mutta korostin myös useaan otteeseen haastateltaville, että he voivat itse lisätä olennaiseksi kokemaansa asiaa riippumatta kysymyksistä. Koen hyvänä merkkinä sen, että lisättävää ei paljon ilmennyt. Kysymykseni eivät myöskään olleet kovin tarkkoja vaan pyrin antamaan aiheita, joista haastateltavat kertoisivat omin sanoin mahdollisimman paljon. Jaoin haastattelurunkoni kolmeen osa-alueeseen: alkuasetelman hahmottelu, prosessin aikana ja jälkiarviointi.

Haastattelun aluksi kerroin näistä osa-alueista haastateltaville, joten haastattelu oli jaettu kolmeen osaan, joiden yksityiskohtiin paneuduimme järjestyksessä muodostaen näin kokonaiskuvan hankkeesta. Haastattelujen aikana oli tärkeää keskittyä, että kuunnellessani ymmärsin kai-

ken ja olin valmis esittämään tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa. Haastateltavat kertoivat yksityiskohtaisesti odotuksistaan ja tavoitteistaan. Kehittämisasiantuntijan haastattelussa tärkeäksi teemaksi muodostui hanketyön oppiminen tekemällä ja siihen liittyvät haasteet. Toimintakulttuuri tuli vahvasti esiin ensimmäisessä haastattelussa tarkentavien kysymysten yhteydessä, joten osasin painottaa tätä aihepiiriä enemmän kahdessa seuraavassa haastattelussa.

David ja Sutton (2011) korostavat kysymysten laatimisessa tavoitteellisuutta, eli kysymysten on liityttävä tutkittavaan asiaan. Tästä lähtökohdasta tutkija luo teemoja, joiden kautta haastattelujen rakenne syntyy. Tutkimuksen perusteella päätetään, käytetäänkö suljettuja vai avoimia kysymyksiä tai kenties jotain niiden väliltä. Kysymysten olisi perustuttava tutkijan tulkintoihin kirjallisuudesta tai vaihtoehtoisesti tutkijan aikaisemmin keräämään tietoon haastattelujen, havaintojen tai arkistomateriaalien kautta. Teemojen löydyttyä tutkija laatii täsmentäviä kysymyksiä ja pohtii haastattelun käytännön toteutusta. Teemoja ja alakysymyksiä käytetään ohjenuorana, mutta niiden orjallinen noudattaminen ei ole välttämätöntä, paitsi jos se on todettu tutkimuksen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Kysymyksiä voidaan siis käydä läpi järjestyksessä tai niitä voidaan tuoda esiin keskustelussa haastattelijan harkinnan mukaan. Joskus on suositeltavaa ottaa haastattelun alkuun lämmittelykysymyksiä, joiden avulla luodaan luottamusta ja hyvää henkeä haastattelijan ja haastateltavan välille. Haastattelun aikana peruskysymysten lisäksi on hyvä varautua esittämään syventäviä kysymyksiä, jos vastaukset jäävät pinnallisiksi sekä selvittäviä kysymyksiä varmistamaan, että haastateltava on ymmärtänyt esitetyt kysymykset oikein. Erilaisia haastattelun elementtejä harjoittelemalla tutkija pystyy reagoimaan paremmin annettuihin vastauksiin. Kysymykset ovat silta haastattelijan ja haastateltavan välillä. Huonosti laaditut kysymykset voivat johtaa virheellisen informaation välittymiseen osapuolten kesken. Siksi olisikin suositeltavaa pyytää asiantuntijoita tai kollegoja arvioimaan ja testaamaan kysymyksiä käytännössä. Kieli on aina avain haastattelussa ja kielen kautta kvalitatiivinen tieto kerätään ja tuotetaan. Niinpä kysymykset on laadittava siten, että haastateltava ymmärtää ne haastattelijan tarkoittamalla tavalla. (David & Sutton 2011, 122–123.)

Aineisto on täysin itse kerättyä, haastattelut suoritettiin suojaisassa paikassa eikä materiaalia ole jaettu. Aineisto jää tutkijan hallintaan ja vastuulle tutkielman ajaksi ja se tuhotaan tutkielman valmistuttua. Haastattelut ovat sekä äänitetyssä että kirjallisessa muodossa litteroinnin jälkeen ja ne on numeroitu lähdeviittausta varten. Haastatteluista otettuja lainauksia on muokattu lievästi luettavuutta ajatellen eli niihin on lisätty välimerkit ja niistä on poistettu osa täytesanoista kuitenkin säilyttäen alkuperäinen puhekieli.

Analyysiluvuissa viitataan haastateltuihin nimikkeillä toiminnanjohtaja (FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtaja), kehittämisasiantuntija (Siun soten Auttava omainen -hankkeen vetäjäksi valitsema henkilö) ja hanketyöntekijä (Siun soten rahoittama hanketyöntekijä). Analyysiluvuissa on käytetty runsaasti lainauksia aineistosta aineistolähtöisyyden havainnollistamiseksi. Muistiinpanoista, arviointikeskusteluista ja suunnittelu- ja koulutusmateriaaleista ei ole lainauksia, mutta niitä käytetään analyysin tukena. Tutkielman teon ohessa tallensin ideoita ja mahdollisesti käyttökelpoista lähdekirjallisuutta muistioihin.

2.4 Tutkimusetiikka ja tutkijan positio

2.4.1 Tutkimusetiikka

Antropologisella tutkimuksella on Rob Whitleyn (2014) mukaan kolme toisiaan tukevaa roolia mielenterveyteen liittyen. Nämä roolit ovat kritisoida psykiatrian toimintatapoja, uskomuksia ja liikkeitä, valaista mielisairauteen liittyvää kärsimyksen ja parantamisen sosiaalista ja kliinistä kontekstia ja tuottaa positiivista kehitystä henkisestä ahdingosta tai mielisairaudesta kärsivien ihmisten parantamiseen, palveluihin ja tulevaisuudennäkymiin. (Whitley 2014, 507.) Positiivinen muutos on eettisesti tärkeä osa mielenterveysaiheista tutkimusta. Tämän tutkielman eettisenä tavoitteena on tuoda esiin omaisten asemaan liittyviä epäkohtia sekä mahdollisia tapoja auttaa vahvistamaan omaisten asemaa. Erityisesti kiinnitän huomiota omaisen yksilölliseen huomiointiin ja siihen liittyviin epäkohtiin esimerkiksi perhekeskeisen hoitotavan yhteydessä.

Tämän tutkielman kannalta eettisesti haastavaksi muodostui tutkittavan hankkeen pienimuotoisuudesta johtuva tunnistettavuus. Koska tutkielma ei tuottanut eettisesti arveluttavia tuloksia eikä tutkittavien toiminnassa paljastunut tutkielman yhteydessä moitittavaa, on paikkakuntakohtaiset tiedot jätetty tekstiin. Tutkittavien henkilöllisyyttä ei paljasteta, mutta Auttava omainen -hankkeen tunteville he ovat tunnistettavissa, mistä tutkittavat ovat tietoisia. On epäselvää auttaisiko paikkakuntienkaan sensurointi täysin anonymisoimaan tutkielmaa. Selvää puolestaan on, että tutkittavat toimivat omaisten aseman puolesta puhtain motiivein, joten mitään vahinkoa tutkittaville ei tutkielmasta koidu. Näin ollen tutkittavista muodostuvaan kuvaan on kiinnitetty huomiota tutkielmaa tehtäessä alusta alkaen, kuten Vakimo (2010) ohjeistaa: tutkimuksessa tulee huomioida tutkittavista muodostuva kuva ja pyrkiä rakentamaan tutkimus siten, ettei tutkimustuloksia voida käyttää tai tulkita väärin. Tutkija tuottaa aina tietynlaisen kuvan tutkittavista, ja tämä voi johtaa tutkittavien yhteiskunnallisen aseman muuttumiseen myös tutkijan tahtomatta. (Vakimo 2010, 100.)

Tutkielman pienimuotoisuus on myös syy sille, että tutkielmaan ei yritetty ottaa mukaan mielenterveysomaisia. Asiasta keskusteltiin alustavasti, mutta omaisia ei haluttu missään tapauksessa kuormittaa tutkimuspyynnöllä kokeiluasteella olevan palvelun yhteydessä, koska palvelu oli suunnattu avun tarpeessa oleville ihmisille, joiden jaksaminen oli mahdollisesti koetuksella.

Hain tutkielmaan Siun sotelta tutkimusluvan, johon sisältyi erikseen lupa Siun soten henkilökunnan haastattelemiseen. Haastateltavien kanssa sovittiin haastatteluista suullisesti ja sähköpostitse. Haastateltavat tiesivät hyvin mihin he ovat osallistumassa, ja koko tutkielman keston ajan minun ja tutkittavien välillä vallitsi hyvä yhteisymmärrys. Sekä kehittämisasiantuntija että toiminnanjohtaja ovat lukeneet ja hyväksyneet haastattelujen pohjalta tehdyt johtopäätökset ja tulkinnat. Toimitin työn myös hanketyöntekijälle luettavaksi, mutta häneltä ei tullut vastausta.

Tutkimustyössä on noudatettava tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Muiden tutkijoiden työtä tulee kunnioittaa ja viitata heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Nämä periaatteet ovat ohjanneet tämän tutkielman tekoa yhdessä opintojeni tuoman kokemuksen kanssa.

Olen pyrkinyt parhaani mukaan johtamaan analyysini ja teoriani aineistosta käsin noudattamalla grounded theoryyn pohjaavaa tieteellistä toimintatapaa.

2.4.2 Tutkijan positio

Otin jo opintojen varhaisessa vaiheessa tavoitteekseni käsitellä sekä kandidaatin tutkielmassa että pro gradu -tutkielmassa henkilökohtaisesti merkittävää nyky-yhteiskunnan ilmiötä. Vaikka en toteuttanutkaan puhtaasti etnografista tutkimusotetta, oli työskentelyssäni kuitenkin etnografisia elementtejä. Kulttuuriantropologia tieteenalana mahdollistaa joustavan tutkimusotteen. George Marcusin (1998) mukaan on olemassa kasvava tarve keskitetyille kenttätyöprojekteille, jotka käsittelevät maantieteellisiin kulttuurialueisiin keskittyvien perinteiden ulkopuolelle sijoittuvia aiheita ja ongelmia. Perinteinen lähtökohta etnografisen tutkimuksen suunnittelussa vie tutkijan kauas omasta piiristään. Tarvittava vieraantuminen tutkimuskohteesta suoritetaan valitsemalla kohteeksi kulttuurisesti huomattavan erilainen ympäristö totuttuun verrattuna. Näin ollen omaan yhteiskuntaan liittyvien tutkimusten on oletettu olevan liian lähellä tutkijaa, että tämä edes kattavan itsereflektion myötä pystyisi irtautumaan subjektiivisuudesta, joka liittyy tutkimuskohteen tuttuuteen. Kuitenkin tutkijan yhteys tutkimuskohteeseen tuo parhaimmillaan tutkimukseen sekä motivaatiota että mielenkiintoa. Tutkijan henkilökohtaisesta yhteydestä kumpuava yleistys tuo projektille sisältöä ja antaa vakaan pohjan, jolle rakentaa tutkimuksen uskottavuutta sosiaalisten tieteiden perinteiden mukaisesti. Avaimena toimii tutkimuskohteesta etääntyminen ja sen tarkasteleminen tieteellisesti ja mahdollisimman objektiivisesti kuitenkin kaiken aikaa huomioiden oma yhteys tutkimuskohteeseen. (Marcus 1998, 12–16.)

Henkilökohtainen kokemukseni mielenterveysomaisena antoi minulle mahdollisuuden tarkastella Auttava omainen -hanketta sekä tutkijan että omaisen eli palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tutkielmaa tehdessäni minun piti huomioida omat ennakkoluuloni psykiatrisen hoidon ja omaisten kohtelun suhteen. Omat kokemukseni ovat monelta osin negatiivisia, joten tähän oli erityisesti kiinnitettävä huomiota mahdollisten vinoutumien syntymisen ehkäisemiseksi. Toisaalta tutkielmani kohteena ollut Auttava omainen -hanke ja siihen liittyvät ihmiset eivät millään tavoin

vahvistaneet ennakkoluulojani, joten uskon pystyneeni kohtelemaan tutkielmaa riittävän objektiivisesti. Tulkinnassa on siis huomioitu oma subjektiivisuus.

Omat kokemukseni omaisten kohtelusta ovat kahdelta eri paikkakunnalta. Omaisen ensisijainen funktio on näissä yhteyksissä ollut tiedonantajana toimiminen, ja henkilökunnan toiminta on aina ollut hyvin rutiininomaista. Rutiinit ovat olennainen osa toimintakulttuuria, joten omaisen kohtelun muutoksen täytyy tapahtua nimenomaan rutiinien uudistamisen kautta. Tämän tutkielman ytimessä onkin vahvasti se, miten omainen hahmotetaan eri yhteyksissä ja mitä merkityksiä omaiselle annetaan. Tiedonantajan roolille on oma tehtävänsä hoidon toimintamallissa, joten omainen sijoittuu rutiininen viitoittamana omalle paikalleen lähes automaattisesti. Kun omaista kohdellaan tiedonantajana, inhimillisyys jää taka-alalle. Kun rooleja vahvistetaan kerta kerralta läheisen hoitosuhteen kestäessä, alkaa omainenkin omalta osaltaan toteuttaa odotusten mukaista toimintamallia. Omainen tulisi siis nähdä kokonaisvaltaisemmin koko hoitoprosessin ajan, että tämä toimisi hoitoprosessissa omana itsenään eikä pelkästään tiedonantajana.

Vertaisomaisten koulutuksissa harjoiteltiin toimimista kaikissa Auttava omainen -hankkeen rooleissa: omaisena, vertaisomaisena sekä terveydenhuollon ammattilaisena eli omaisneuvojana. Vertaisomaisen tehtävänä oli toimia autettavan omaisen tukena oman kokemuksensa pohjalta, kun omaisneuvoja keskittyi ammattilaisen näkökulmaan. Eri roolien kokeilemisen myötä osallistujat saivat kokonaiskuvan siitä, miten toimintaa pyrittiin käytännössä toteuttamaan. Minulle tutkijan ominaisuudessa nämä koulutukset toimivat eräänlaisena peilinä, josta rooleihin kohdistuvat odotukset tulivat näkyviin. Toimiessani itse vertaisomaisen roolissa sain kokea kuinka hankala tehtävä voi olla. Kun toimitaan vapaaehtoispohjalta vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa, on tärkeää pitää huolta myös vapaaehtoisen jaksamisesta ja roolien selkeydestä. Koulutuksissa korostettiinkin sitä, että palvelun tarkoituksena ei ole hoitaa omaista vaan tarjota tukea ja kuunnella omaista ihmisenä.

Charlotte Aull Daviesin (1999) mukaan refleksiivisyys tarkoittaa tutkimuksen tekoprosessin ja siihen osallistuneiden ihmisten vaikutuksen huomioimista tuloksissa. Tutkijan subjektiivinen koke-

mus ja sosiokulttuurinen suhde tutkimuskohteeseen täytyy sisällyttää tutkimukseen, koska tutkijan työskentely suodattuu näiden vaikuttimien kautta. Tutkija pystyy arvioimaan ajatusprosessejaan ja työskentelyään paremmin, kun hän huomioi oman positionsa tutkittavaan kohteeseen nähden. Davies sanoo tutkimuksen tarkoituksen olevan lisätä ymmärrystä erilaisten todellisuutta koskevien näkemysten välillä ja toimia siltana, jota pitkin tulkinnat ja vaikutteet voivat siirtyä molempiin suuntiin. (Davies 1999, 4–6.) Vaikka oma analyysini nojaa vahvasti haastattelumateriaaliin, se jäisi huomattavasti ohuemmaksi ilman osallistumistani palavereihin ja koulutuksiin. Osallistumiseni myötä pystyin hyödyntämään empatiakykyäni ja eläytymään tutkittavien kokemukseen, mikä on olennainen osa etenkin tulkintojani mielenterveysomaisten kokemusten vaikutuksesta toimintakulttuurin muutoksen motivoijana. Huomioimalla oman kokemukseni ja ennakkoluuloni mielenterveyspalveluista pystyin minimoimaan niiden vaikutuksen tutkielmaan. Edellä kuvatun perusteella koen onnistuneeni valaisemaan mielenterveysomaistyöhön ja -omaisiin liittyviä erilaisia näkökulmia tieteellisen käytännön mukaisesti.

3 Teoreettinen viitekehys

3.1 Suunnittelu ja toimintakulttuuri

Otto (2013) sanoo, että design eli suunnittelu on olennainen osa ihmiskunnan toimintaa ja sen vaikutusta voidaan pitää yhtä arvokkaana kuin tieteen, taiteen ja teknologiankin. Antropologisen tutkimuksen siirtyessä alkukantaisista kulttuureista tutkijan omaan ympäristöön, on luonnollista, että suunnittelu ja antropologia kohtaavat, sillä suunnittelu tapahtuu ihmisiä varten. Antropologia antaa keinoja suunnittelun ja sen päämäärien ymmärtämiseksi niitä käyttävien ihmisten näkökulmasta. Etenkin etnografinen tutkimus on suunnittelun kannalta hyödyllinen työtapa, sillä sen avulla päästään tutustumaan tuotteiden ja palveluiden toimintaan käytännössä. Näin kehittäminen ja innovointi ovat vankemmalla pohjalla, kun käyttäjien tarpeet ja kokemukset tulevat osaksi prosessia. Suunnittelun tulevaisuusorientoituneisuus ja realiteettien muuttamiseen tähtäävät käytännöt antavat antropologialle hyviä mahdollisuuksia kehittyä perinteisestä kulttuurien vertailusta modernin maailman kuvaamista ja kehittämistä tukevaksi tieteenalaksi. Suunnittelun ja antropologian kohdatessa siis molemmat hyötyvät. Antropologi voi oppia pelkän seuraamisen sijaan myös muuttamaan ja kehittämään tarkasteltavaa ilmiötä ja sen vaikutuspiirissä olevia muuttujia. Suunnittelijalle puolestaan antropologian perinteiset vahvuudet teoretisointi, kontekstualisointi ja kulttuuristen tulkintojen tuottaminen avaavat uusia näkymiä ja syventävät ymmärrystä sosiaalisesta todellisuudesta, johon suunniteltavia tuotteita tai palveluita kehitetään. Antropologinen lähestymistapa auttaa myös huomioimaan suunnittelun vaikutuksen arvokysymyksiin, jotka liittyvät erilaisiin ryhmiin vähemmistöistä kuluttajiin ja tuottajiin. Antropologin roolin kehittyessä tarkkailusta osallistumiseen on vaatimuksena yhteistyön tekeminen ja uusien tutkimustapojen kehittäminen uhraamatta empatiaa ja ymmärryksen syvyyttä. (Otto 2013, 1–4.)

Tässä tutkielmassa en osallistunut suunnittelutyöhön, mutta tutkielma tuo esille antropologian kykyä havainnollistaa suunnittelun eri osa-alueita. Tutkielman tuloksena syntyy teoria, jonka avulla pyritään muuttamaan toimintakulttuuria. Näin antropologian hyöty suunnittelun kehittämisessä tulee näkyviin.

Scheinin (2017) mukaan kulttuuri tarkoittaa organisaation kontekstissa rakenteellista vakautta, syvyyttä, leveyttä ja vakiintuneita käytäntöjä. Rakenteellisen vakauden ytimessä on ryhmäidentiteetti, joka hyvin vahvana elementtinä ehkäisee muutosten syntymistä. Kulttuurin näkyvät osat ovat ryhmän jäsenten välisen kanssakäymisen määrittelemiä. Mitä rituaalisempaa tämä kanssakäyminen on sitä enemmän se vahvistaa kulttuurin vakautta. Jäsenten vaihtuvuuden myötä kulttuuri uudistuu ja etsii ratkaisuja tästä syntyviin ongelmiin. Kulttuuri on siis sekä vakaa että dynaaminen. Syvyydellä tarkoitetaan kulttuurin ydintä eli itsestään selviä uskomuksia, arvoja ja käyttäytymismalleja. Kulttuurin leveys puolestaan huomioi organisaation kaikki toiminnot eli tehtävät, strategian, rakenteen ja operationaaliset prosessit, koska ne ovat jaetun oppimisen tulosta ja rajoittavat organisaation mahdollisuuksia muutokseen. Vakiintuneet käytännöt viittaavat ihmisen tarpeeseen toimia merkityksellisellä tavalla eli ne sitovat yhteen organisaation rituaalit, arvot ja käyttäytymismallit järkeväksi kokonaisuudeksi, mikä auttaa järjestämään toiminnan yhdenmukaiselle ja ennustettavalle pohjalle. (Schein 2017, 10–11.)

Psykiatrisessa hoidossa, ja etenkin perhekeskeisessä hoitotavassa, kulttuurin näkyvät osat tulevat esiin erityisen vahvasti hoitokokouksessa. Hoitokokouksessa jokaisella osallistujalla on hyvin selkeä rooli, jota toteutetaan kerta toisensa jälkeen hyvin samalla tavalla. Hoitokokouksessa on siis kaava, jota noudatetaan. Lisäksi hoitokokoukseen latautuu hyvin vahvoja odotuksia sekä potilaan että omaisten osalta, koska se on usein ainoa mahdollisuus tavata suurta valtaa potilasta kohtaan käyttävää psykiatria. Potilas odottaa tilaisuutta vaikuttaa omaan tilanteeseensa, kun mahdollisuus tavata psykiatri kasvokkain toteutuu. Omaisten odotukset ovat korkealla, koska uutta tietoa potilaan tilasta kaivataan. Etenkin ennen diagnoosin varmistumista hoitokokousta luonnehtii vahvasti epävarmuus, johon psykiatrilta odotetaan helpotusta. Nämä latautuneet tunteet ja valmiit kaavat muodostavat hoitokokouksesta hyvin rituaalinomaisen. Hoitokokouksen roolit toisintavat itseään sen ulkopuolella, kun niitä on vahvistettu tässä rituaalinomaisessa tapahtumassa.

Organisaation rituaalit, arvot ja käyttäytymismallit ovat avainasemassa tässä tutkielmassa, jonka ytimeksi paljastui aineistolähtöisesti toimintakulttuurin muutos. Ryhmäidentiteetti ja ihmisen

tarve toimia yhdenmukaisella ja ennustettavalla pohjalla ovat vahvoja vastavoimia muutokselle. Myös pienet resurssit ja esimiesten välinpitämättömyys hankaloittavat muutoksen toteuttamista, koska ulkoista painetta ei synny. Muutoksen kannalta olisikin hyödyllistä tunnistaa ja analysoida vakiintuneet käytännöt mahdollisimman perinpohjaisesti, että niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Tämä tutkielma esittelee keinoja rutiinien murtamiseksi. Rutiinien muuttaminen on hidas prosessi, jonka tärkeimmät voimavarat ovat hyvä motivaatio ja pitkäjänteinen sitoutuminen muutostyöhön.

Hyvärinen, Lee ja Mattelmäki (2015) sanovat, että julkinen sektori on viime aikoina tiedostanut yhteiskunnan muista rakenteista erillään olevien palvelurakenteiden olevan riittämättömiä kehittämään ja ylläpitämään riittäviä palveluita perinteisessä hyvinvointiyhteiskunnassa. Myös Suomessa etsitään jatkuvasti vaihtoehtoisia ratkaisuja uudenlaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi vaihtoehdoista on rakentaa eri sektoreiden yhdessä ylläpitämä palveluverkosto, joka tukee uusia yhteistyön muotoja. Tällainen toimintatapa on julkiselle sektorille suuri muutos, kun siirrytään organisaation sisällä tapahtuvasta palvelun kehittämisestä yhteistyössä tehtävään suunnitteluun. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on löytää yhteinen ja kaikille osapuolille hyödyllinen tavoite, mutta myös sitoutuminen toiminnan jatkuvaan kehitykseen ja muutokseen. Sitoutuminen paranee, jos tavoitteet muodostuvat työryhmän toiminnan tuloksena sen sijaan, että ne annettaisiin ylemmältä taholta valmiina. Näin ollen jokaisen osallistuvan yksilön roolit ja motivaatiot tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön mielekkyys lisääntyy, jos voidaan luottaa kumppaneiden olevan innostuneita ja sitoutuneita toiminnan jatkumiseen. Yhteisen suunnitteluprojektin konfliktit voivat toimia katalysaattorina organisaatioiden muutoksille, kun niiden toimintamalleja joudutaan arvioimaan erilaisissa viitekehyksissä. (Hyvärinen ym. 2015, 262–266.)

Auttava omainen -hankkeen myötä terveydenhuolto joutui arvioimaan toimintamallejaan uudestaan. Suunnittelutyö paljasti omaisten kohteluun liittyviä epäkohtia, joita alettiin korjaamaan pikkuhiljaa. Tämä tutkielma on erinomainen esimerkki suunnittelun ja yhteistyön tuomasta uudesta näkökulmasta, joka motivoi muuttamaan toimintakulttuuria.

Haastattelujen perusteella yksi Auttava omainen -hankkeen tärkeimmistä tavoitteista oli muuttaa mielenterveyshoitajien suhtautumista omaisiin. Omainen tulisi nähdä yksilönä eikä sairastuneen yhteydessä huomioitavana sivuhahmona. Jos omainen kokisi hoidon eri yhteyksissä tulevansa huomioiduksi omana itsenään, voisi vuorovaikutuskin olla luonnollisempaa ja tehokkaampaa. Omaisen ottaessa tiedonantajan roolin muuttuu väistämättä myös käytös, kun omainen toteuttaa tiedonantajan roolia kanssakäymisessä. Mielenterveystyössä sairastunut on ollut niin kauan keskiössä, että toimintaan on kehittynyt hyvin vahva rutiini. Panostaminen perhekeskeisyyteen ei ole tuonut muutosta tähän asiaan. Samankaltaista ongelmaa pohdiskelevat Gunn ja Ventura (2017) lääketieteellisten tuotteiden suunnittelua koskevassa artikkelissaan. Suunnittelijat kaipaavat enemmän aikaa tutkimuksen tekoon ja suunnitteluprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin. Design-antropologian avulla suunnitteluun saadaan refleksiivisyyttä sen eri vaiheisiin, jolloin suunnittelun kohteet voidaan paremmin huomioida ihmisinä. Antropologia voi tuoda suunnitteluun syvällistä sosiaalikulttuurista ymmärtämystä ja laajentaa suunnittelijoiden perspektiiviä ongelmanratkaisusta käyttäjien näkökulman huomioivaan ajatteluun. (Gunn & Ventura 2017, 52.)

Blomberg & Darrah (2015) ja Johnson, Pfister & Vindrola-Padros (2015) kertovat artikkeleissaan antropologisesta palvelusuunnittelusta. Antropologian soveltaminen suunnitteluun tuottaa paremmin tarvetta vastaavia palveluita ja auttaa laajentamaan perspektiiviä palvelua käyttävästä yksilöstä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Lisäksi antropologinen lähestymistapa ottaa huomioon palvelun jatkuvan uudistumisen käytännön työssä, ja sen mukanaan tuomat odottamattomat seuraukset. (Blomberg & Darrah 2015, 93; Johnson ym. 2015, 186–187.)

Gunn & Løgstrup (2014) sanovat, että suunnittelun osapuolien täytyy ymmärtää toistensa näkökulmia. Yhteistä tarttumapintaa ongelmaan rakennetaan kartoittamalla jaettua ymmärrystä ja tulevaisuuden visioita. Yhteistyön kehittyessä toiminnan kautta päästään paremmin sisälle kumppanien ajatusmaailmaan ja toimintatapoihin eli suunnittelussa rakennetaan askel askeleelta parempaa yhteisymmärrystä. (Gunn ja Løgstrup 2014.) Omassa tutkielmassani tämä on hyvin oleellinen asia, sillä Siun soten ja FinFamin alueyhdistyksen toimintatavat ovat hyvin erilaiset jo pelkästään resurssien pohjalta. Molemmin puolin etenkin suunnittelun alkuvaiheessa oli

totuttelua yhteistyökumppanin tapoihin. Iso tekijä tässä oli suuri kokemusero omaisasioiden hoitamisessa. FinFamin alueyhdistyksen koko toiminta perustuu omaisiin, kun Siun sotella omaisten huomiointi oli jäänyt perhekeskeisen lähestymistavan varjoon ja omaisia piti opetella kohtaamaan uudella tavalla. Tutkielma havainnollistaa ajan kanssa tapahtuvaa näkemyserojen tasaantumista ja lähentymistä.

3.2 Kulttuuriantropologia ja mielenterveys

Jenkinsin (2015) mukaan kulttuuriantropologian ja psykiatrian suhde on taas lämpenemässä pitkän tauon jälkeen. 1900-luvun puoliväliin saakka nämä tieteenalat olivat tiiviissä yhteistyössä ja ruokkivat toisiaan. Psykiatrian panostus neurologiaan aiheutti kulttuurin ja yhteisöllisyyden merkityksen lähes täydellisen sivuuttamisen. Myös kulttuuriantropologian saralla mielenterveyteen liittyvät aiheet siirtyivät pois keskiöstä. Antropologialla on kuitenkin keskeinen rooli mielisairauden vaikutusten kartoittamisessa eri elämänaloilla. Mielisairauden tutkimus on olennainen osa antropologista kulttuurin ja kokemuksen ymmärtämistä sekä vastavuoroisesti kulttuurin ja kokemuksen ymmärtäminen on tärkeä osa mielisairauden tutkimusta. (Jenkins 2015, 7.)

Tuohela (2012) sanoo, että terveys ei ole teoreettisesti määriteltävissä, vaan se neuvotellaan kussakin kulttuurisessa tilanteessa aina uudelleen. Tauti tai sairaus on näin dialogissa oman aikansa muiden ilmiöiden kanssa ja sitä tulisi tarkastella suhteessa yksilön kokemukseen ja yhteisön jaettuihin arvoihin ja käytäntöihin. Kulttuurin muovaamat toimintatavat ja huomaamatta opitut asenteet ohjaavat suhtautumista terveyteen ja sairauteen. Sairaus on sosiaalisesti jaettua ja historiallisesti muuttuvaa, joten sitä määritellään jatkuvasti uudelleen. Sosiaalisina ilmiöinä sairaus ja terveys ovat myös arvottavia käsitteitä, jotka osallistuvat hyvän, toivottavan ja oikean sekä niiden vastakohtien eli pahan, väärän ja ei-toivotun tuottamiseen. (Tuohela 2012, 59–60.)

Parantuminen erilaisista mielenterveyden häiriöistä ei tapahdu tyhjiössä, joten sairastunut ja usein myös hänen omaisensa ovat vaarassa jättäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle odotellessaan hoidon tehoamista. Psykiatria haluaa kohdella sairastunutta samoin kuin muutkin lääketieteen

alat eli keskittyä hoitoon ja jättää hoidon ulkopuoliset asiat sairastuneen ongelmiksi. Kun yhteisöllisyys ei kuulu osaksi hoitoprosessia, jää omaisten huomiointi helposti vähäiseksi. Kuitenkin mielisairautta olisi kohdeltava osana yhteiskuntaa ja elämää eikä siirrettävä sitä marginaaliin. Antropologia voi näytellä suurta roolia muutoksen toteuttamisessa, koska se on tieteenalana hyvin joustava. Mielenterveyden häiriöt voidaan syrjimisen sijaan kohdata ja päästä selville kaikesta siitä, mitä ne kertovat ihmisistä ja yhteiskunnasta. Jenkinsin (2015) mukaan ihmisten erilaiset tavat hahmottaa todellisuutta ovat olennainen osa mielisairauden tutkimusta, ja mielisairauden tutkimuksen kautta on mahdollista päästä kosketuksiin ihmisen kokemuksen rajojen kanssa. On selvää, että ihmisten henkilökohtainen kokemus mielisairaudesta tai sen sosiaalinen kohtaaminen eivät tapahdu välinpitämättömästi, koska mielisairauksiin liittyy aina monimutkaisten prosessien suodattamia tunteita. (Jenkins 2015, 10.)

Tämä tutkielma valaisee omalta osaltaan hoitokäytäntöihin liittyviä tekijöitä ja pyrkii parantamaan omaisen asemaa. Omaisten yksilöllinen huomiointi voi omaisen henkilökohtaisen voinnin kohentumisen lisäksi toimia yhteisöllisyyden kehittäjänä ja sitä kautta luoda yhteiskunnallista hyvinvointia. Perhekeskeisen hoitotavan käsittelyn myötä esittelen yhteisöllisyyden merkitystä nykyaikaisessa psykiatrisessa hoidossa, mutta kiinnitän samalla huomiota siinä esiintyviin puutteisiin.

Alami (2014) sanoo, että hoitokäytäntöjen parantamiseksi on huomioitava sekä potilaan tilanteelleen antamat merkitykset että toiminnallinen ympäristö. Sairaus ja sen syy, terapeuttiset ratkaisut sekä lääkkeiden määrääminen voidaan antropologisen tutkimuksen yhteydessä tulkita sosiaalisiksi representaatioiksi, jotka ylläpitävät terveyteen liittyviä käytäntöjä. Representaatioiden ja käytäntöjen analysoiminen tuottaa informaatiota sosiaalisesta todellisuudesta, jossa sairastuneen ja hänen kanssaan tekemisissä olevien ihmisten näkökulmat kohtaavat. Antropologinen tutkimus mahdollistaa yksilöllistä käyttäytymistä ohjaavien, organisoivien ja rajoittavien materiaalisten, sosiaalisten ja symbolisten tekijöiden tarkastelun suhteessa terveyteen ja sairauteen. Potilaskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa yleensä keskittymistä potilaan uskomuksiin, pelkoihin ja odotuksiin, mutta parempiin tuloksiin päästään tarkastelemalla sosiaalista verkkoa, johon kuuluvat olennaisesti omaisten näkökulmat ja valtasuhteet terveydenhoidon kontekstissa. Näin ollen

hoitokäytännöt tulisi nähdä osana suurempaa prosessia, jota tulkitaan ihmisten tavoitteiden, käytäntöjen ja kiinnostuksen kohteiden kautta sen sijaan, että pyritään muuttamaan yksilön käyttäytymistä informaation avulla mekaanisesti. (Alami 2014, 241–243.)

Jenkinsin (2015) mukaan kulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka mielisairauteen ja sairastuneeseen suhtaudutaan. Jo yhden perheen sisällä voi olla suurta vaihtelua. Ääripäissä ovat rakkauden ja kiintymyksen suodattama näkemys sekä epäilevä ja jopa vihamielinen tapa käsitellä asiaa. Yleensä tunnereaktiot muodostuvat tällaisten suodattimien läpi ja objektiivisuus on harvinaista. Lähipiiriin suhtautumisella on joka tapauksessa suuri rooli sairastuneen pärjäämisessä taudin kanssa ja lopulta myös toipumismahdollisuuksissa. (Jenkins 2015, 101–102.)

Lähipiirin jäsenet suhteuttavat läheisen mielisairauden kokemukseensa ympäröivästä maailmasta ja kulttuurista. Stigmaa yritetään minimoida, jolloin sairautta sovitetaan normaalin elämän muotteihin. Mielisairaus ei kuitenkaan koskaan täysin asetu kulttuurisesti määrittyvän normaalin piirissä oleviin luokitteluihin tai tapoihin. Koska mielisairauden vaikutuksia sairastuneeseen ja lähipiiriin on hyvin vaikea ennakoida ilman aiempaa kokemusta, korostuu mielikuvien merkitys etenkin sairauden puhjetessa ensimmäistä kertaa. Ainoa mahdollisuus sopivien käsitteiden puuttuessa on tyytyä erilaisiin monitulkintaisiin termeihin, asenteisiin ja toimintamalleihin, jotka suodattuvat mielisairauteen liittyvistä kulttuurisista kokemuksista ja mielikuvista. Näitä termejä, asenteita ja toimintamalleja purkamalla voidaan kehittää parempia keinoja sanallistaa sekä sairastuneiden että heidän omaistensa kokemusta.

Auttava omainen -hankkeen suunnittelussa jouduttiin pohtimaan käyttäjän, eli tässä tapauksessa mielenterveysomaisen kokemusta, että palvelu toimisi omaisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelun tulisi antaa omaiselle työkalut käsitellä omaa tilannettaan ja samalla huomioida omaisen tilanteen herkkyys. Omaisen kokemusta voidaan kartoittaa vapaaehtoisten avulla luomalla koulutuksia, joissa palveluun sisältyviä rooleja harjoitellaan. Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen on toinen tapa tutustua omaisen kokemukseen. Kokemusasiantuntijan tehokkuus perustuu tunnepohjaisen reaktion synnyttämiseen henkilökohtaisen tarinan kertomisen avulla.

Osallistumalla itse harjoitukseen, jossa osallistujat toimivat vuorollaan kaikissa palvelun rooleissa eli asiakkaana, vertaisomaisena ja omaisneuvojana, tavoitin tutkielmani kannalta olennaisia henkilökohtaisia kokemuksia ja tarinoita. Nämä kokemukset ja tarinat olivat omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että tutkielmassa käsitellään tunteiden vaikutusta toimintakulttuurin muutokseen. Avoin keskustelu ja palautteen antaminen harjoituksen jälkeen avasi näkökulmia ja kokemuksia entistä paremmin. Kokemusasiantuntijan vaikutus puolestaan oli selvästi havaittavissa tarkkailemalla kuuntelijoiden reaktioita.

Anna Kinnusen (2020) mukaan mielen sairastamiseen liittyvät kulttuuriset käsitykset eivät ole ainoastaan todellisuuden representaatioita, vaan myös tulkintoja kaikesta, mitä mielen sairastamisesta on aikaisemmin esitetty. Kulttuurisen ajattelun jatkuvuus tarkoittaa siis ajassa tapahtuvia siirtymiä, joissa käsitykset kerrostuvat toistensa päälle. Näin se, millaisena todellisuus on mahdollista esittää, määrittyy edeltävien tulkintojen asettamien mallien ja reunaehtojen kautta. (Kinnunen 2020, 51.) Toisin sanoen muutoksen aikaansaaminen edellyttää uusien tulkintojen ja käsitysten tuottamista ja kerrostamista kulttuurisen ajattelun jatkuvaan muutoksen tilaan. Tämän tutkielman kontekstissa tämä tarkoittaa uusien merkitysten tuottamista omaisen asemaa ja kokemusta koskien suhteessa aiempiin käsityksiin omaisen asemasta psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteydessä.

4 Hankkeen alkuasetelma: neuvottelua tavoitteista ja aikataulusta

Alkuasetelmaa analysoitaessa on tärkeää huomioida erot odotuksissa, jotka syntyvät toiminnanjohtajan kokemuksen ja kehittämisasiantuntijan kokemattomuuden vastakkainasettelusta. Odotusten erot tulevat näkyviin tarkasteltaessa käsityksiä projektin ja sen eri vaiheiden vaatimasta ajasta. Yhteistyön kautta päästään samalle aikajanalle, jolloin tavoitteet voidaan asettaa realistisesti.

Auttava omainen -hankkeen kehittäminen lähti liikkeelle tarpeesta huomioida omainen paremmin. FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtajaa pyydettiin suunnittelemaan ministeriössä valittujen toimintamallien perusteella toteutettavaa, omaisille suunnattua uutta palvelua alkukesällä 2016. Mielenterveysomaisten huomiointi oli yksi valtakunnallisen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen (I&O-kärkihanke) tavoitteista. Pohjois-Karjalan ja Siun soten toimesta toteutettu Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT) -hanke oli osa valtakunnallista I&O-kärkihanketta. Yksinkertaisin ministeriön koostamista toimintamalleista olisi vaatinut ainoastaan omaisen voinnin tiedustelua psykiatrisella osastolla, kun Auttava omainen -malli oli monimutkaisimpia sen vaatiessa kokonaisen uuden palvelun kehittämistä ja aktiivista järjestöyhteistyötä.

Terveydenhuollon ja FinFamin alueyhdistyksen yhteistyöllä on pitkä historia Pohjois-Karjalassa, mutta se oli hiipunut vuosien saatossa. FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtaja ei osannut eritellä syitä yhteistyön hiipumiseen. Toiminnanjohtaja otti siis mahdollisuuden yhteistyön kehittämiseen mieluusti vastaan, vaikka hänen odotuksensa eivät olleetkaan korkealla. Psykiatrisen osaston johto valitsi koostetuista vaihtoehdoista Auttava omainen -mallin. Toiminnanjohtaja piti mallia haastavana sen monimuotoisuuden vuoksi, mutta erityisesti sen sisältäessä niin paljon vapaaehtoistoimintaa.

Myös rahoitus ja työvoiman riittämättömyys huolettivat tässä vaiheessa. Siun soten puolelta kuitenkin järjestyi rahoitus hanketyöntekijälle, joka toimi sekä FinFamin alueyhdistyksen että Siun

soten yhteydessä. FinFamin alueyhdistyksen resurssit eivät olisi riittäneet kehittämään Auttava omainen -hanketta ilman tätä lisätyövoimaa. Kolmantena osapuolena oli pienimuotoisesti mukana Pohjois-Karjalan muisti ry, koska palvelun potentiaalia haluttiin kokeilla myös tässä ympäristössä. Tähän tutkielmaan ei Pohjois-Karjalan muisti ry:n näkökulmaa otettu mukaan, koska työ keskittyy mielenterveysomaisiin.

Siun sotella psykiatriselle osastolle palvelua jalkauttamassa oli sairaanhoitajia, ylihoitaja ja osastonhoitaja. Vapaaehtoiset sairaanhoitajat myös osallistuivat suunnitteluun kehittämispalavereissa. Esimiehet olivat sitoutuneet palvelun jalkauttamiseen. Lisäksi Auttava omainen -hanke kosketti myös päihdepalveluita, jotka ovat linkittyneet hyvin tiiviisti mielenterveydenhoitoon. Usein näiden palveluiden asiakkailla on ongelmia sekä päihteiden että mielenterveyden kanssa, joten rajanvetoa on hankala tehdä.

AVOT -hankkeen aikana tapahtui terveydenhuollon uudistus, kun Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Uudistus aiheutti suuria mullistuksia terveydenhuollon toimintaan, mikä oli otollinen tilaisuus kokeilla jotain uutta mutta toisaalta aiheutti kiirettä ja päänvaivaa henkilöstölle. Näin ollen Auttava omainen -hankettakin ajettiin sisään poikkeusoloissa.

AVOT -hankkeen suunnitelmassa Auttava omainen -toimintamallia kuvattiin koulutetun vertaisneuvojan ja ammattihenkilön työparitoiminnaksi. Ammattihenkilö keskittyy potilaiden auttamiseen ja akuuttiin tilanteeseen, kun vertaisneuvoja kuuntelee ja rauhoittaa omaista. Vapaaehtoistoiminnan kautta oli tarkoitus luoda uusia mahdollisuuksia ja resursseja palvella potilaita ja heidän omaisiaan paremmin. Aikaa pidettiin otollisena hankkeen toteuttamiselle, koska psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut keskitettiin pääosin Joensuun keskussairaalan yhteyteen kesällä 2016. Psykiatriatalossa myös avattiin järjestöhuone ”Linkki”, jossa on mahdollisuus järjestää vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa sekä yhteistyötä psykiatrian osastojen kanssa. Haasteena pidettiin ammatillisen työn ja vapaaehtoistyön yhdistämistä kokemuksen puuttuessa. Siispä suun-

nitelmassa painotettiin arjen kokemusta ratkaisevana tekijänä toiminnan juurruttamisessa. Pidemmän aikavälin tavoitteena oli kunta-järjestöyhteistyön levittäminen laajemmalle sosiaali- ja terveydenhuollossa. (AVOT -hankesuunnitelma 2016, 24.)

Työ aloitettiin hyvässä hengessä ja motivaatio oli korkealla, koska omaisen parempi huomiointi oli kaikille tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Etenkin FinFamin alueyhdistykselle tämä toimi mahdollisuutena päästä paremmin mukaan terveydenhuollon toimintaan, mitä oli muutoinkin tavoiteltu jo pidemmän aikaa. Analysoidessani alkuasetelmaa pyrin hahmottelemaan lähtökohtia, joista palvelua lähdettiin kehittämään sekä eri osapuolien näkökulmia edessä odottavaan haasteeseen.

4.1 FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtajan odotukset ja tavoitteet

Toiminnanjohtajan odotukset ja tavoitteet pohjautuivat ammattitaitoon ja kokemukseen. Hänelle Auttava omainen -hanke näyttäytyi mahdollisuutena kehittää mielenterveysomaistyötä koko maakunnassa. Aluksi keskeisiksi teemoiksi nousivat ajankäyttö sekä toiminnanjohtajan ja Siun soten nimeämän kehittämisasiantuntijan odotusten erot, jotka perustuivat mielenterveysomais- ja hanketyön tuntemukseen:

> *Toiminnanjohtaja: Jos on jotkut odotukset, joitten takia kokee, että tässä tulee takapakkia niin sellasiahan voi ihmisillä olla, mutta miun mielestä ei mulla ainakaan ollu sellasia. Voi olla, että (kehittämisasiantuntijalla) oli ehkä odotuksia, että hän ei tuntenu tätä kenttää niin paljo, että ois kokenu niitä asioita niin hyvin, että ois tuntenu. Ja miten Siun sote on sitte asettanu ne odotukset, et niissä voi olla semmosta ehkä vähän epärealistista, että esimerkiks nää omaisten tietoillat et niihin tulis paljo ihmisiä, ni heillä ois semmoset odotukset, mut sit taas mulla on semmoset odotukset, että apua että tuleekohan sinne ketään et tulis ees yks ihminen. Että henkilöstöö lähtee yks ihminen ja tuleekohan enempää, ku se henkilöstö paikalle. Niin sellaset ehkä heillä on eri näkemys, ku meillä niihin asioihin. (H3.)*

Toiminnanjohtaja suhtautui Auttava omainen -hankkeeseen kokemuksensa perusteella realistisesti. Hänen odotuksensa muokkautuivat hanketyön edetessä sen näyttäessä potentiaalinsa. Siun soten odotukset tietoiltoihin osallistuvien ihmisten määrästä hän näki epärealistisina, koska paikkakunnan mielenterveysaiheiset tilaisuudet ovat normaalisti pienimuotoisia. Samoin mahdollisten vapaaehtoisten löytäminen ei toiminnanjohtajan mielestä ollut helppoa. Siun soten näkemys mielenterveysomaistyön arjesta ei vastannut todellisuutta, joten odotukset eivät perustuneet tietoon vaan johonkin muuhun. Liian suuret odotukset ihmisten osallistumista kohtaan kertovat osaltaan omaisen asemasta Siun soten piirissä. Läheisen sairastumisen vaikutusta elämään ja omaisten halukkuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan ei osata arvioida oikein. Tämä kertoo siitä, että omaisen arjen haasteita ei täysin ymmärretä. Myöskään paikkakuntakohtaiset erityislaatuisuudet mielenterveysomaistoiminnassa eivät ole tiedossa, mikä johtuu järjestötoiminnan ja Siun soten yhteistyön puutteesta. Toiminnanjohtajalle ero odotuksissa näyttäytyi asiana, joka järjestyy ajan kanssa. Odotusten tasaantuminen tapahtuu käytännön työssä, kun realiteetit konkretisoituvat.

Koska FinFamin alueyhdistyksen toiminnanjohtaja ei uskonut vapaaehtoisten löytymiseen, otti hän kokemuksensa pohjalta hieman erilaiset tavoitteet hankkeelle kuin sille oli virallisesti määritelty:

> *Toiminnanjohtaja: Mulla oli odotukset, että jos nää muut osiot lähtis hyvin, että nää omaisneuvojat jos ois näitä omaisneuvojakoulutuksia, ni se oli heti semmonen hyvä, että jos tää nyt käynnistyy ni tästä on aina hyötyy. Ja sit se omaisneuvonta, että se tulis siun sotelle ni jos seki vaikka lähtis liikkeelle, ja tietenki nää on helpoimpia järjestää nää omaisten tietoillat, ni niitten tekeminen ei mikään vaikee oo ni aattelin että ne nyt on ainaki… Sit vaan se et, miten saa ne vapaaehtoset innostumaan, ni aattelin, et se ei onnistu nopeesti, mutta nää muut asiat aattelin, että saa ehkä aika helpostiki toimii. (H3.)*

Toiminnanjohtajalle tärkeintä oli siis saada konkreettisia omaisten oloja parantavia muutoksia aikaan omaisten tietoiltojen, vapaaehtoistoiminnan ja omaisneuvonnan muodossa. Auttava

omainen -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti riippui vapaaehtoisten löytymisestä, joten sitä ei voinut pitää varmana. Ulkopuolisen rahoituksen myötä tilaisuus oli joka tapauksessa hyvin tärkeä, koska oli mahdollisuus tehdä asioita, joihin ei koskaan olisi pystytty järjestön omin voimavaroin. Lisäksi houkuttimena oli FinFamin alueyhdistyksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön parantuminen. Toisin sanoen tarkoituksena oli hyödyntää tilaisuus kehittää omaistoiminnan eri osa-alueita Auttava omainen -hankkeen ohessa, vaikka hankkeen tavoitteet eivät toteutuisikaan sellaisinaan. Toiminnanjohtaja piti myös tärkeänä saada toimintaa järjestöhuone Linkkiin, koska se oli yksi tilaisuus lisää parantaa yhteistyötä Siun soten kanssa.

4.2 Kehittämisasiantuntijan odotukset ja yhteisymmärryksen luominen

Työhön käytiin käsiksi heti kun Siun soten puolelta valittiin kehittämisasiantuntija tehtävään. Kehittämisasiantuntijan kokemus psykiatrisen osaston hoitotyöstä oli hyödyksi, kun haettiin hoitajia kehittämistyöhön ja vapaaehtoisiksi kokeilemaan palvelua käytännössä. Lisäksi hoitokokemus auttoi työryhmää keskittämään huomiota olennaisiin asioihin, kun omaisen asemaa hoitotyössä arvioitiin. Kehittämisasiantuntijan odotukset poikkesivat huomattavasti toiminnanjohtajan odotuksista, koska hänellä ei ollut kokemusta hanke- tai omaistyöstä:

> *Kehittämisasiantuntija: No odotuksethan oli aika kovat ja ajattelin, että ihan kaikki tavotteet saahaan kyllä saavutettuu ja niinku tietysti vähän pelko siitä, että miten ne saahaan saavutettuu ja onko mulla tarpeeks tukijoukkoja siihen ja ehkä omassa organisaatiossa tuntu vähän siltä, että siellä ei oltu ihan loppuun asti mietitty mihinkä on sitouduttu. Mutta sitten taas, ku tulin täällä FinFamilla käymään, ni täällä oli jo silleen että ihan selkeet suunnitelmat, että miten edetään ja ilman FinFamin tukea ei se ois lähteny oikein eteenpäin… Hanketyöstä ei varsinaisesti ollu kokemusta, et just semmonen oli aika hakemista, että missä aikataulussa pitää saada aikaseks, että välillä kiirehti liikaa sit välillä taas junnas jotkut asiat paikallaan, ei oikein osannu rajata työtehtäviä et mikä on olennaista ja mikä on epäolennaista et ihan opetteluu oli alussa näiden asioiden kanssa ja varmasti seuraavaan projektiin ku lähtee ni valmiudet on paremmat. (H2.)*

Kehittämisasiantuntijalla oli edessään hanketyön ja omaisasian opettelu käytännön kautta. Kehittämisasiantuntijan odotuksia ohjasivat vahvasti hänen luja työmoraalinsa ja positiivinen asenteensa. Hän ei ollut mukana alustavassa suunnittelussa, joten hän ei tiennyt Auttava omainen -hankkeen yksityiskohdista tullessaan valituksi kehittämisasiantuntijan tehtävään. Vasta suunnitelmiin tutustumisen myötä tehtävän luonne alkoi paljastua kokonaisuudessaan. Samalla alkoi pikkuhiljaa tehtävään sopivan työtavan opettelu, jossa järjestöpuolen kokemus hanketyöstä auttoi. Käytännössä tämä tarkoitti järjestöyhteistyön ja aikataulutuksen opettelua sekä olennaisten asioiden erottamista epäolennaisista. On huomionarvoista, että hän kuvaa tehtävää ”muutoksen eteenpäin viemiseksi”. Jo alusta asti oli siis selvää, että Auttava omainen -hankkeen ytimessä on saada aikaan muutos.

Alussa oli tärkeää luoda hyvät olosuhteet uuden palvelun kehittämiselle, mikä tarkoitti ennen kaikkea työntekijöiden tutustumista toisiinsa ja yhteisten suuntaviivojen löytämistä. Työryhmän pienuuden ansiosta tekijät pääsivät yhteisymmärrykseen varsin pian eivätkä henkilökemiat aiheuttaneet myöhemminkään ongelmia. Järjestöpuolen rutinoitunut ote ja valmis suunnitelma auttoivat rauhoittamaan tekemistä. Toisaalta kehittämisasiantuntijan positiivinen ja toimelias asenne oli omalta osaltaan helpottamassa työn käynnistämistä, kuten toiminnanjohtajan haastattelusta ilmenee:

> *Toiminnanjohtaja: Tietysti kehitysasiantuntija (kehittämisasiantuntija) ku alotti työt, ni hänen tehtävähän se on pitää lankoja käsissä eri yhteistyötahoihin ja organisoida asioita ja viedä eteenpäin yhteistyötahojen kanssa. Ja (kehittämisasiantuntija) alko hoitaa asioita ja mun mielestä hän hoiti tosi hyvin kaikki ne asiat, että ne suju hyvin, että sitten ainaki aluks pidettin enemmän niitä yhteispalavereja, että päästiin samalle kartalle, mutta se oli (kehittämisasiantuntijan) kanssa tosi helppoo, että se rakentu kyllä hyvin että mukava oli tehä sitä ja semmonen hyvä meininki siinä, että hyvin suju hänen kanssaan yhteistyö. (H3.)*

Toiminnanjohtajalle tuli yllätyksenä, miten hyvin työ lähti sujumaan. Kokemuksensa perusteella hän odotti käynnistymisvaikeuksia, mutta niitä ei ilmennyt:

> *Toiminnanjohtaja: Niin no se voi tietysti olla, et jos ei oo ikinä missään projetissa ollu aikasemmin ni voi tuntuu hitaalta. Mulle taas toisinpäin että ku oon monessa projektissa ollu, ni tuntu et täähän lähti tosi hyvin, että ihan eri vinkkeli siinä mielessä et se odotuksista riippuu aika paljo. (H3.)*

Tiiviit palaverit mahdollistivat työryhmän vahvan keskusteluyhteyden, ja näkemyserot ajankäytön ja etenemisen suhteen tasaantuivat nopeasti. Siirtymä odotusten muovaamasta alun epävarmuudesta tehokkaaseen työskentelyyn oli lopulta lyhyt hyvän yhteistyön ansiosta. Kehittämisasiantuntijan tehokkuus toimessaan oli avain hankkeen käynnistymisen sujuvuuteen. Toiminnanjohtajan vanhat kontaktit puolestaan auttoivat suuresti tietoiltojen ja koulutusten järjestämisessä tarvittavaa verkostoitumista.

Organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit eivät myöskään aiheuttaneet ristiriitoja, vaan työryhmä alkoi heti hakea omaa tapaansa viedä asioita eteenpäin. Hanketyöntekijä kuvaa eroja seuraavasti:

> *Hanketyöntekijä: Täällä (FinFami) on nää muutamat työntekijät ja muutaki hommaa mitä tekemässä ja tietysti mie tein sitä tiettyy osiota ja siinä osallistuin muihinki hankkeen eri osioihin, ku tähän auttavaan omaiseen ja tietysti siinä toisessa paikassa (Siun sote) on paljo ihmisiä samassa paikassa ja kuka menossa mihinkii koko ajan et semmonen vähä hektisempi ja aktiivisempi tavallaan siellä se sisäinen toimintakulttuuri erilainen varmasti, mutta tietenki ku semmonen avoin ja lämmin ilmapiiri siellä hyvin toimi se yhteistyö. On se aina erilaista varmasti joka paikassa. (H1.)*

Hanketyöntekijä viittaa kulttuurieroihin organisaatioissa. Siun sotella on hektisempi ja aktiivisempi toimintakulttuuri ja paljon enemmän ihmisiä töissä kuin FinFamin alueyhdistyksessä. Toimintakulttuurien erot kenties vaikuttivat kehittämisasiantuntijan odotuksiin Auttava omainen -

hankkeesta. Terveydenhuollon arkeen ei kuulu pitkäjänteisen hanketyön tekeminen, joten aikajänteen hahmottaminen saattoi olla vaikeaa tästäkin syystä. FinFamin alueyhdistyksessä tekeminen on hidastempoisempaa ja erilaisia hankkeita tulee vastaan tasaisin väliajoin, joten toiminnanjohtajan odotukset perustuivat kokemukseen hanketyöstä. Hanketyöntekijän kuvaama avoin ja lämmin ilmapiiri näyttäytyi myös minulle toimintaa seuratessani ja se toimi tehokkaan työskentelyn perustana luomalla tekemiseen hyvän yhteishengen.

FinFamin alueyhdistyksen ja Siun soten välillä toiminut hanketyöntekijä suhtautui Auttava omainen -toimeksiantoon analyyttisesti. Hänelle oli alusta asti selvää, että yhteistyö on hankkeen kantava voima. Suurempia odotuksia hänellä ei alkuun ollut, enemmänkin toive siitä, että jotain konkreettista saataisiin aikaan. Työn edistymisen kannalta oli tärkeää keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, ja kehittää Varsinais-Suomen mallista paikkakunnalle sopiva versio.

Paikkakuntakohtainen soveltuvuus nousee esiin myös muualta aineistosta eli Varsinais-Suomen malli ei toiminut sellaisenaan. Suurin ero syntyy mahdollisten osallistujien ja vapaaehtoisten määrästä, mikä selittyy pitkälti vertailemalla paikkakuntien väkilukuja. Lisäksi väki on Pohjois-Karjalassa levittäytynyt suurelle alueelle. Paikkakunnat ovat kaukana toisistaan, joten omaisten tavoittaminen on haasteellista. FinFamilla tiedettiin kokemuksesta, että omaiset eivät mielellään liiku kotipaikkakunnaltaan omaistoiminnan vuoksi. Sosiaalinen media ja muu sähköinen viestintä oli todettu tehottomaksi keinoksi tuoda uusia omaisia toiminnan pariin. Facebook- ja twitterkanavat koskettivat lähinnä ennestään toimintaan tutustuneita henkilöitä. Omaisten tavoittamiseksi kehitettiin tietoillat, joita järjestettiin keskeisillä paikkakunnilla. Omaisia yritettiin saada liikkeelle antamalla mahdollisuus kuunnella ja esittää kysymyksiä lähellä kotia.

Työtä pohjustettiin käymällä Turussa tutustumassa Auttava omainen -palvelun kehittäneen FinFamin Varsinais-Suomen alueyhdistyksen toimintaan. Siellä palvelu oli ollut tässä vaiheessa toiminnassa muutaman vuoden, joten työryhmä sai käytännön tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Pohjois-Karjalan mallia lähdettiin kehittämään tämän toiminnassa olevan palvelun pohjalta, joten pidettiin tärkeänä kohdata tietolähteenä toimivia, Auttava omainen -palvelun Varsinais-Suomalaisia toimijoita kasvokkain myös jatkossa tapahtuvan konsultoinnin sujuvuuden kannalta:

Toiminnanjohtaja: Mulle tuli semmonen kuva, että ku hän tuli tähän kehittämisasiantuntijaksi niin siinä pääs tapaamaan ihmisiä, jotka ja tietysti itekki pääsin tapaamaan ihmisiä, jotka on konkreettisesti tehny sitä työtä niin uskosin, että se varmaan siinä oli hyvä. Ja sitten tämmöset kasvokkaiset tapaamiset ku on, ni se tahtoo helpottaa keskinäistä yhteydenpitoo, että on hyvä, että uudet ihmiset tapaa kasvokkain. (H3.)

Suuntaviivat alkoivat hahmottua, kun vierailun jälkeen pohdittiin Pohjois-Karjalaan sopivaa toteutusmallia ja alettiin koostamaan koulutuksia sekä omaisten tietoiltojen sisältöä. Hanketyöntekijällä oli ratkaiseva rooli koulutusten suunnittelussa ja koostamisessa. Hän poimi valmiista mallista Pohjois-Karjalaan sopivat osat ja tuotti niistä koulutuskokonaisuuksia toteuttamista varten. Käytännössä tämä tarkoitti erityisesti osallistujien vähäisen määrän huomiointia. Koulutuksista valittiin ne, jotka pystyttiin toteuttamaan pienimuotoisemmin kuin Varsinais-Suomessa.

Hanketyön suhteen kokeneen toiminnanjohtajan ja kokemattoman kehittämisasiantuntijan näkemykset ajankäytöstä erosivat huomattavasti. Kun työ eteni poikkeuksellisen vauhdikkaasti toiminnanjohtajan mielestä, oli kehittämisasiantuntija ihmeissään kokemastaan hidastempoisuudesta:

Toiminnanjohtaja: varmaan ite ajattelen, että ku oli hahmottunu se oma mielikuva siitä, et minkälainen se tulevaisuus pitäs olla, et missä vaiheessa pitää mitäki olla valmiina, et minkälaiset nää vuosirytmit on eri organisaatioissa ja tässä meillä niin sen mukasesti sitä, että jos ei tuu mitään yllätyksiä, ni oli semmonen hahmotelma mielessä, et mihin mennessä pitäs jotaki saada aikaan ja mitä asioita voi yhistää ja mitä jo voi kehittää. (H3.)

Kehittämisasiantuntija: Ihmiset ku sisäistää sen mistä on kysymys ni vie aikaa, et se jos alkaa tammikuussa hanke ni meillä on jo helmikuussa osa siitä toiminnassa ja mie ehkä kuvittelin, että meillä on jo omaisneuvontaa siellä helmikuussa, mut ei se ihan niin mee. Et ensin piti käydä tiedottamassa ihmisiä, puhumassa, et mistä on kyse ja

> *siinä tietysti on se murto-osa, jotka siinä vaiheessa kiinnostuu ja sähköpostiviestii paljo, että nyt ollaan tässä ja tässä vaiheessa menossa ja tämmöstä on tulossa ja sanosinko, et se vei semmosen ainaki puol vuotta aikaa, että sitä ees jollaki lailla sisäistää ihmiset. (H2.)*

Ajankäytön hahmottaminen on olennainen osa hanketyötä. Tavoitteet on suhteutettava realiteetteihin, koska mikään ei tapahdu hetkessä. Käsitys ajasta toimii omalta osaltaan yhteistyön pohjana, koska aikataulun järkevä laatiminen pitää toiminnan sujuvana eikä turhaa stressiä synny. Vaatimustaso pysyy samana eri osapuolien kesken, kun tavoiteajat on sovittu yhteiseltä pohjalta. Aikataulut ovat myös suuressa roolissa itse suunnittelutyössä, kun työaikaa käytetään aikataulujen päivittämiseen, tarkasteluun ja muokkaamiseen. Aineisto-otteista käy jälleen ilmi toiminnanjohtajan ja kehittämisasiantuntijan kokemusero. Toiminnanjohtaja pystyi hahmottamaan kokonaisuuden ja työn eri osa-alueiden kehitysmahdollisuudet sekä ottamaan huomioon organisaatioiden erilaiset vuosirytmit. Kehittämisasiantuntija puolestaan joutui muokkaamaan käsitystään ajankäytöstä hankkeen eri osa-alueilla moneen kertaan ennen kuin hanketyön rytmi hahmottui.

Toimijoiden ja yhteistyötahojen aikatauluista täytyy löytää sopivat raot koulutusten, palaverien, tietoiltojen ym. toteuttamiseen. Kalenterit päivittyvät, ja merkintöjä syntyy, siirtyy ja poistuu. Kehittämisasiantuntijan täytyi vakuuttaa osastoilla toimivat ihmiset toiminnan hyödyllisyydestä, mikä vei paljon aikaa. Yksittäiset aikataulun muutokset eivät olleet ratkaisevia, kunhan suuret linjat pitivät:

> *Kehittämisasiantuntija: Oli suunniteltu omaisen tietoiltoja ja olin suunnitellu, että meen työryhmän kokoukseen puhumaan ni niitä saatto peruuntua tai ei löytyny sitä yhteyshenkilöö taas tai jotain semmosta ulkonaisista tekijöistä riippuvia tekijöitä, jotka sotki sitä hommaa. Mutta muuten kyllä pysyttiin ihan aikataulussa. Autto varmaan se koulutusrunko käytiin kertaalleen läpi kokonaan. (H2.)*

Samoin myös suunnittelussa runko on tärkein osa, yksityiskohdat järjestyvät muokkaamalla. Suunnittelurunko elää ajassa yksityiskohtien asettuessa paikalleen toiminnan kautta.

Alkuasetelman analysoinnin kannalta keskeisiksi teemoiksi nousevat odotusten erot ajankäytön, tavoitteiden ja aktiivisten omaisten määrän suhteen sekä yhteisymmärryksen luominen. Tärkeä teema on myös osallistaminen, joka liittyy yhteistyön kehittämiseen työryhmän ja yhteistyökumppanien kesken, mutta myös omaisten tavoittamiseen. Asioita pyrittiin alusta asti hoitamaan kasvokkain mahdollisimman paljon siinä toivossa, että kontaktit säilyvät ja vahvistuvat. Kysymyksessä oli siis hyvin inhimillinen toimi, josta kehittyi sydämen asia tekijöilleen. Suunnittelun edetessä tavoitteet elivät ja muuttuivat olosuhteiden muovatessa saavutettavissa olevia lopputuloksia. Suunnittelussa olosuhteet huomioitiin jatkuvasti, eikä epärealistisia tavoitteita asetettu. Työryhmä oli tutustumisvaiheen jälkeen hyvin tietoinen hankkeen pienimuotoisuuden, paikkakuntakohtaisten erikoisuuksien ja vapaaehtoisten vähyyden aiheuttamista rajoitteista, mikä omalta osaltaan teki työstä luontevaa.

Suunnittelun ohjenuorana toimi itsearviointikaavake, jota kokoonnuttiin täydentämään tasaisin väliajoin. Päivittämällä kaavaketta saatiin kokonaiskuva hankkeen tilasta ja edistymisestä. Kun työryhmä saatiin ajan tasalle ja kaikki hahmottivat kokonaisuuden, suunniteltiin seuraavia tavoitteita ja käytiin läpi mahdollisia kehitysehdotuksia:

> *Kehittämisasiantuntija: Sitä arvioitiin sillä tavalla, että AVOT -hankkeessa oli itsearviointi, että siihen oli ihan selkee suunnitelma, ja se oli yhen viiva kahen kuukauden välein siinä täytettiin semmonen itsearviointikaavake. Kaikki työryhmän jäsenet täytti sitä ite, ja sit tavattiin ja tehtiin yks yhteinen kaavake siitä, että mitä on tehty, mitä on opittu, mitä kehitettävää on ja se toimi hyvänä ohjenuorana siinä että mihinkä suuntaan. Et siinä saatto sitten nähä, et hei ollaan tehty jo näin paljo kaikkee, et omassa päässä ainaki tuntu, et ei oo tehty juuri mitään ja sit, ku se lista oli siinä, et nää on jo tapahtunu ja mistä on opittu ja mitä pitää vielä muokata ja mitä pitää kehittää ja missä aikataulussa. (H2.)*

Tehty työ konkretisoituu, kun se kootaan tekstin muodossa näkyväksi. Työryhmän taito välittää omia näkökulmia keskustelussa oli suunnittelun kannalta tärkeä asia. Uudet oivallukset syntyivät usein keskustelun tuloksena, kun hankkeen vaikutuksia pohdiskeltiin käytännön työhön liittyen. Keskusteluissa päädyttiin usein hyvin perustavanlaatuisten kysymysten äärelle, kun puhuttiin omaisten kärsimyksestä tai avuttomuuden tunteista. Näistä keskusteluista havainnollistui erilaisia merkityksiä, joita suunnittelu tuotti. Näitä olivat esimerkiksi ymmärryksen herääminen omaisten asiasta, kun keskusteluissa käytiin läpi osastoilla vallitsevia tapoja kohdata omainen. Omaisten kokemuksen pohdiskelu toi uuden ulottuvuuden hoitajien työhön rutiinien kyseenalaistuessa. Samalla koetettiin löytää keinoja välittää keskustelujen synnyttämiä ajatuksia laajemmalle hoitoyhteisössä.

Alkuasetelman hahmottelun myötä olen pyrkinyt valaisemaan alun tavoitteita ja haasteita erityisesti työryhmän odotuksia vertailemalla. Työn edetessä käytännön realiteetit muokkasivat sen luonnetta ja omaisen asema ja kokemus nousivat keskiöön etenkin terveydenhuollossa. Kehittämisasiantuntijan tutustuessa FinFamin toimintaan ja perehtyessä Auttava omainen -hankkeen myötä omaisten arkeen, muuttui hänen suhteensa tehtävään työhön. Omaisen kokemuksen avautuminen synnytti uudenlaista empatiaa omaisia kohtaan. Samalla työntekijöitä saatiin sitoutumaan omaisen aseman parantamiseen yhä vahvemmin, kun tietoisuus omaisen kokemuksesta parani. Seuraavassa luvussa analysoin suunnittelun kehittymistä ja keskittymisen siirtymistä yhä enemmän toimintakulttuurin muutokseen.

5 Toimintakulttuuri nousee keskiöön

Aikaisemmin todettiin työryhmän kehittäneen oman toimintatapansa, joka perustui tekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä aikaisempaan työkokemukseen. Yhteisen sävelen löydyttyä työtä tehtiin tehokkaasti ja asetetuissa tavoitteissa pysyttiin hyvin. Toiminnanjohtajan pelkäämä vapaaehtoisten puute alkoi kuitenkin näkyä suunnittelutyössä ja tavoitteita jouduttiin muokkaamaan. Vapaaehtoisten puuttuessa keskityttiin enemmän omaisneuvonnan toimintaan osastoilla. Hoitajia tarvittiin omaisneuvojiksi, joten hoitajien motivointi nousi vahvasti esiin. Kehittämisasiantuntijan panos kärsi hänen jouduttuaan jakamaan työaikaansa Auttava omainen -hankkeen ulkopuolelle, mikä aiheutti omat haasteensa.

Tässä tutkielman kannalta tärkeimmässä luvussa käsitellään muutosta rutiininomaisesta hanketyöstä tunnepohjaiseen, jopa intohimoiseen suhtautumiseen tehtävään työhön. Auttava omainen -hankkeesta tuli aiottua vahvemmin toimintakulttuurin muutokseen tähtäävä operaatio. AVOT -hankkeen suunnitelmassa puhutaan toiminnan juurtumisesta arkeen, kun ihmiset näkevät ja kokevat sen omassa työssään ja elämässään (AVOT -hankesuunnitelma 2016, 24–25). Toimintakulttuuri ei ollut johtava teema hankesuunnitelmassa tai käytännön työssä. Toimintakulttuurilla tarkoitan tutkielmani kontekstissa psykiatrisen erikoissairaanhoidon työyhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita toimintatapoja.

Toimintakulttuurin muutosta toteutettiin monella eri tasolla, joista tärkeimmäksi muodostui ruohonjuuritason toiminta, jossa hoitajia koetettiin vakuuttaa omaisen huomioinnin tärkeydestä. Ruohonjuuritasolla tarkoitan hoitajien kesken tapahtuvaa kommunikointia, jossa omaisasiasta vakuuttuneet hoitajat levittivät sanomaa osastoilla. Johtoporras oli sitoutunut nimellisesti toimintaan, mutta panostus jäi epämääräiseksi aineiston perusteella. Johtavaksi teemaksi nousee omaisen kokemuksen ymmärtäminen, johon kytkeytyy kaikki oleellinen toimintakulttuurin muutoksesta psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä. Ymmärrys omaisen kokemuksesta auttaa ja motivoi huomioimaan omaista paremmin, kun omaiseen voidaan suhtautua kokonaisvaltaisemmin eikä omaista nähdä pelkästään tiedonantajana. Omaisen kokemuksen ymmärtäminen lisää

empatiaa omaista kohtaan, jolloin kohtaamisesta tulee inhimillisempi rutiininomaisen ja virallisen kohtelun jäädessä taka-alalle.

5.1 Auttava omainen -hanke muokkautuu vapaaehtoisten puuttuessa

Hoitajien saaminen mukaan oli haaste. Tähän olisi kaivattu suurempaa velvoitetta esimiesten taholta, mutta toimintaan sitoutui lopulta muutama ydinhenkilö, jotka toimivat myöhemmin myös sanansaattajina osastoilla koettuaan asian tärkeäksi:

> *Kehittämisasiantuntija: Ehkä siihen ois voinu olla vähän isompiki työryhmä ja tosi iso haaste tässä oli saada sinne omaisneuvonnan koulutukseen ihmisiä, että tässä ois pitäny enemmän olla semmosta velvotetta esimiesten taholta työntekijöille, että tää koulutus pitää käydä mahollisimman monen. Että sitten tuli niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka kävi koulutuksen ja koki tän asian hyvin tärkeeksi, mutta nyt jos lähtis ihan uudelleen tätä projektia viemään eteenpäin, ni kokoisin isomman työryhmän. Ei liian isoo, mutta semmonen että siinä ois just FinFami, sit tämmönen hanketyöntekijä ja siun sotesta vielä enemmän ois ihmisiä. (H2.)*

Toimintakulttuurin muutoksen kannalta hoitajien osallistaminen on olennainen asia, joten suurempi velvoite käydä koulutuksissa olisi ollut erittäin hyödyllistä. Vaikka koulutuksissa käyneet hoitajat levittivät sanaa, ei se vastaa omaa kokemusta koulutuksista. Myös kehityspalavereissa nostettiin esiin, että osastoilla tapahtuva ”läksytys” ei toimi. Tässä on löydettävissä ensimmäinen linkki tunnepohjaisen reaktion tehokkuuteen. Kollegoiden välinen keskustelu ei motivoi muuttamaan käyttäytymistä, mutta hyvin järjestetty koulutus puolestaan motivoi tehokkaasti. Toimintakulttuurin muutos edellyttää ihmisten sitoutumista, ilman sitä ei saavuteta mitään pysyvää.

Kehittämisasiantuntija ei kokemattomuuttaan osannut vaatia johtoa sitouttamaan enemmän henkilökuntaa hankkeeseen. Jos hankkeella olisi alusta asti ollut laajempi vaikutuspiiri, suunnitteluun olisi osallistunut enemmän ihmisiä, mikä olisi todennäköisesti tehostanut ajatustyötä sekä jakanut vastuuta kehittämisasiantuntijan harteilta:

> *Kehittämisasiantuntija: Mulle ilmotettiin suoraan, että nämä työntekijät tulee tähän, mut varsinaisesti hyö oli vaan semmosia, jotka ehkä seuraa enemmän, että miten hanke etenee, et ei varsinaisia niitä jotka tekee. Ja ehkä sitten se semmonen omakin kokemattomuuden puute siinä, et olis pitäny iteki vaatii enemmän, että tässä pitää olla enemmän ihmisiä, että saadaan tää laajasti eteenpäin. Mutta varmasti este on ollu, että siun sote alotti samaan aikaan. Kaikilla työntekijöillä ja esimiehillä ihan valtavasti uusia asioita ja sitten siinä, ku yritetään jotain hanketta ja toimintamallia saada läpi, ni se on haasteellista. Kyllä et se vähä hukkuu sinne muun asian alle helposti. (H2.)*

Siun soten toiminnan aloittaminen toi lopulta enemmän haasteita kuin mahdollisuuksia Auttava omainen -hankkeelle, koska uudistus toi terveydenhuollon henkilökunnalle paljon ylimääräistä työtä ja ajateltavaa. Ruuhkautumista tapahtui työntekijöiden ja esimiesten toiminnan lisäksi mm. viestinnässä. Viestintä oli suunnittelussa tärkeä osa, koska ihmisiä piti saada liikkeelle ja osallistumaan. Siun sote ei ruuhkautumisen vuoksi kyennyt tiedottamaan halutulla tavalla:

> *Kehittämisasiantuntija: Siitä (viestinnästä) on positiivista ja negatiivista, elikä meillä on siun sotessa yks viestintäihminen, ni voidaan olettaa, että ei ihan kaikki mee läpi. Siinä tuli ongelmaa että ei saatu viestittyy siun soten sivuilla auttava omainen toimintamallista muuta, ku näistä tietoilloista, niin ei vaan jostain syystä mee läpi, siellä on niin paljo asiaa. Mutta sittenhän meillä oli oma hankeviestintä siun soten AVOT -hankkeen sivut, mutta sehän ei lähe sitten niin paljo tavota ihmisiä, et se on lähinnä yhteistyökumppaneita ja siun sote joitakii henkilöitä liikuttaa. Jonki verran lehtijuttuja saatiin paikallislehtiin, se oli ihan kiva. Siinä oli kokemusasiantuntija oli parissaki lehtijutussa tais olla mukana omainen. Ja tietysti tosi paljo ihan perinteistä paperiviestintää lappuja seinillä, ja koulutuskalenteri toiminu viestimenä koulutukset on ihmiset nähny. (H2.)*

Näkyvyyttä toivat artikkelit paikallislehdissä, mutta käytännön arjessa jouduttiin turvautumaan paperiviestintään. Paperiviestinnällä tarkoitan erilaisia esitteitä, joita kiinnitettiin seinille ja jaettiin omaisille osastoilla. Hoitajien osallistaminen oli siis viestinnänkin kannalta olennaista. Omaisen huomion saa parhaiten luomalla keskusteluyhteyden osastoilla tai tietoilloissa.

5.2 Omaisen asema perhekeskeisessä hoitotavassa

Perhekeskeisessä hoitotavassa lähtökohtaisesti huomioidaan koko perhe, mutta omaisen yksilöllinen huomiointi jää kuitenkin heikoksi. Kehittämisasiantuntija oli pohdiskellut asiaa ja jopa käynyt sitä läpi osastolla:

> *Kehittämisasiantuntija: Tässä tuli alkuun ristiriita, ku tää hanke alko, ku mie tulin puhumaan omaisneuvonnasta ni oli et hei, myöhän tehään jo tätä perhekeskeistä työotetta. Ni sitte ku ruvettiin osa otti vähä ihteesäkki, et miks tullaan samaa asiaa uudelleen. Mut sit ku puhuttiin tarkemmin, et mitä se perhekeskeinen työote, ni sitä perhettä katotaan kokonaisuutena… Siellä silleen näennäisesti huomioidaan, mutta ei yksilöllisesti nii. Se on ehkä semmonen uudenlainen näkökulma, et sitä asiaa pitää tuoda esille, et se perhekeskeisyys on saatu aika hyvin läpi ajattelumalliin ja työskentelymalliin jostain syystä siihen on varmaan tehty tosi paljo töitä joskus, et se koko perhe pitäs ottaa huomioon, mut tää on sitte taas aika uus asia tämmönen. (H2.)*

Kehittämisasiantuntija kuvaa perhekeskeisyyden ongelmia ytimekkäästi. Hän kertoo ristiriidasta, joka syntyi perhekeskeisen otteen ja omaisneuvonnan välille hoitajien mieltäessä omaisneuvonnan samaksi asiaksi kuin perhekeskeisyys. Keskustelemalla hoitajat kuitenkin löysivät perhekeskeisyyden ongelman eli omaisen yksilöllisen huomioinnin laiminlyönnin. Kehittämisasiantuntijan kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä tuo oikean perspektiivin asiaan ja kyvyn avata asiaa haastattelussa. Omaisten yksilöllisen huomioinnin kokeminen ylimääräisenä työnä kertoo perhekeskeisyyden epäonnistumisesta tässä suhteessa. On ilmeistä, että omaisen yksilöllinen huomiointi ei kuulu perhekeskeiseen työhön ainakaan käytännössä, ja kehittämisasiantuntija viittaakin omaisneuvontaan uudenlaisena näkökulmana. Lisäksi perhekeskeisyys tarkoittaa potilaan läsnäoloa ja

keskipisteenä olemista. Omaisen yksilöllinen huomiointi vaatii siis perhekeskeisyyden jättämistä taustalle. Perhehän jo terminä viittaa yhteisöön yksilön sijasta. Yksilön huomiointi osana yhteisöä on eri asia kuin yksilön huomiointi itsenäisenä henkilönä. Yksilön henkilökohtainen kokemus olisi siis erotettava perheen kokemuksesta.

Omaisen henkilökohtainen kokemus jää varjoon osittain sen takia, että sairastuneen läsnä ollessa on hyvin vaikea puhua omasta jaksamisestaan rehellisesti. Sairastuneen vointi on etusijalla, eikä omainen halua kuormittaa häntä mahdollisilla omilla ongelmillaan:

> *Kehittämisasiantuntija: Et sie voi sanoo siinä sairastuneen läsnäollessa, et mie en jaksa tuota ihmistä, et mie oon aivan jaksamisen äärirajoilla. Et oikeesti tosi rajustiki voi omainen sanoo sairastuneesta, että ei haluu olla samassa tilassakaan, tai se voi yllättääkin, et sieltä voi tulla semmosta tekstiä, mutta ku on uupuneena ni voi kokee niin… Ja kaikki ei ota puheeks. Jotkut tuo kyllä silleen vähä enemmän ilmi just vaikka puhelimessa, että on tässä on aika raskasta tai näin, mut sitten hiljasempiakii omaisia, et niistä on vaikee päällisin puolin tulkita, että voi ollaki aika vaikeeta. Jotenki varsinki nuoret omaiset on semmonen, mihin pitäs enemmän puuttuu. Jotkut joiden puoliso on vaikka sairastunu ni tuntuu, et ne on sopeutunu siihen tilanteeseen, et ei ota enää niin tunteella ja silleen et tästä tää eteenpäin menee. Mut sitte mitä muutamaa nuorta omaista oon tavannu ni kyllä huomaa, et se liikuttaa heiän elämää ihan hirveesti. Se läheisen sairastaminen vaikuttaa kaikkeen osa-alueeseen, se vaikuttaa opiskeluun, työhön, parisuhteeseen kokonaisvaltasesti, et siihen pitäs vielä enemmän puuttuu. (H2.)*

Kehittämisasiantuntija tuo esiin myös hiljaisuuden ja tottumuksen omaisen pahoinvoinnin piiloon jäämisen syinä. Jos omainen ei missään yhteydessä tuo ilmi omia ongelmiaan, ei niihin myöskään voida puuttua. Toisaalta omainen voi olla sopeutunut sairastuneen kanssa elämiseen siten, ettei hän enää hahmota tilanteen ongelmallisuutta. Kehittämisasiantuntija painottaakin terveydenhuollon vastuuta omaisen ongelmiin puuttumisessa, jos omainen ei itse osaa pyytää apua.

Toimintakulttuurin muutos linkittyy olennaisesti omaisen näkemiseen omana itsenään ja hänen kokemuksensa ymmärtämiseen. Omaisen yksilöllisen huomioinnin pohtiminen johtaa väistämättä perhekeskeisen hoitotavan kyseenalaistamiseen. Rutiinit sanelevat käyttäytymistä, mutta omaisasian tiedostaminen voi muuttaa sitä. Haastatteluissa kuvataan tätä asiaa seuraavasti:

> *Kehittämisasiantuntija: Se kohdataan tiedonantajana usein sillä tavalla, että kysellään että mikä on ollu vointi, vaikka ennen tätä sairaalajaksoa tai että miten työ yhessä pärjäätte tai tällä tavalla se menee. Semmosella rutiinilla se menee melkein jokaisessa potilaskontaktissa, mut sit taas sillä on merkitystä, että hoitajat on tietosempia tästä omaistyöstä. Että tässähän hankkeen aikana on tehty varmasti semmosta vaikuttamistyötä sinne hoitohenkilökuntaanki, että hei kysykää vaikka pienesti että mitä sille omaisille kuuluu, ohjatkaa tänne järjestöön FinFamille, ohjatkaa sairaalan omaisneuvontaan, ku on semmoset tahot mitä voidaan tarjota täältä Pohjois-Karjalasta ihmisille, että on toimivat järjestelmät järjestö ja sotepuolella nyt tällä hetkellä. (H2.)*

> *Hanketyöntekijä: Kaikki ei ymmärtäneet, että mitä eroa on omaistyöllä ja perhelähtöisellä työllä. Että mehän on koko ajan tehty tätä, että perheitten kanssa toimitaan, mutta se on eri asia kun omainen itsenään ja heiän hyvinvointi kuin että koko perheen kanssa tehdään työtä sairaan asioissa. Se oli joillekki että miten tässä lisää heille tämmöstä hommaa ja mitä hyötyä tästä on. Vähä semmonen pientä asennetta siihen taustalla joissain paikoissa, et miten se on sit edenny tästä se tietoisuus. (H1.)*

> *Toiminnanjohtaja: Tuli esille jo siellä Turun vierailulla, et siellä onkohan se siinä oppaassakin kirjotettu, että tää omaisasia on eri asia ku perhetyö, niin siitähän se jo vähän avaa sitä ihmisille jotka on psykiatrisella töissä, et mitä se tarkottaa. Et se on heille varmaan vähä eri näkökulma kuitenkii ja sitten siinä on aina omat yhtymäpinnatkii, et ei oo aina tarkkaan eroteltavissa kaikki, et monessa on niitä harmaita alueita missä ne yhtyy, mutta meiän tehtävä oli tuua tätä omaisneuvonnan merkitystä, että omainen huomioidaan omana itsenään ja että jos omaisneuvonta järjestetään niin*

että se on irrallisena potilaan hoidosta. Eli luodaan se järjestelmä, jossa omaisneuvojat on henkilöitä, jotka eivät ole sen potilaan omahoitajia tai saman osaston hoitajia niin sehän siinä oli se idea sitten, mistä se ehkä aukes heilleki et mikä se merkitys on. (H3.)

Perhekeskeisyys on siis erotettava omaisen yksilöllisestä huomioinnista. Aineiston perusteella kysymyksessä on usein täysin uusi asia hoitajille, joten työtä on paljon tehtävänä. Osa hoitajista koki omaisen huomioinnin lisätyönä, mikä aiheutti asenneongelmia. Hoitajat kyseenalaistivat muutoksen tarpeellisuuden, koska perhekeskeinen hoitotapa oli jo olemassa. Omaisen yksilöllinen huomioiminen nähtiin tarpeettomana työtaakan kasvattamisena, koska sen merkitystä ei täysin ymmärretty. Omaisten huomioinnin jatkuvuus riippuukin pitkälti siitä, saadaanko se ajettua sisään rutiineihin. On epäselvää, tulisiko omaisasia sisällyttää perhekeskeiseen malliin vai ajaa sitä itsenäisenä kokonaisuutena sisään toimintakulttuuriin.

Toimintakulttuurin muuttuminen omaisnäkökulman avautuessa tarkoittaa samalla, että tiedonantajan kategoria lähtee laajentumaan. Tiedonantajan rooli on edelleen tärkeä sairastuneen hoidossa, mutta omaisen huomioinnin kannalta kategorian täytyy laajentua kattamaan omaisen koko ihmisyys. Kategorisointi muuttuu omaisasian tiedostamisen kasvaessa automaattisesti.

Omaisen yksilöllisellä huomioinnilla luodaan hyvinvointia koko yhteiskuntaan, mutta etenkin yksilötasolla merkitys voi olla huomattava. Omainen jää usein yksin taakkansa kanssa ja pienikin huomionosoitus voi olla erittäin tervetullut. Konkreettisen avun tarjoaminen tuo aivan uuden ulottuvuuden omaisen kokemukseen hoitotyöhön osallistumisesta. Auttava omainen -hankkeen sisäänajon myötä hoitohenkilökunta sai keinoja erottaa omaisen yksilöllisen huomiointi ja perhekeskeisyys paremmin. Kun omaiselle oli osaston sisällä oma palvelu, johon tämän voi ohjata, tapahtui omaisen yksilöllinen huomiointi luonnollisemmin. Toiminnanjohtajan kokemus asiasta:

Toiminnanjohtaja: Ihmiset on puhunu, että heillä ois ollu helpompi ottaa yhteyttä ja kysellä omaisen kuulumisia ja sitten siinä auttaa seki, että voi konkreettisesti tarjota, ku sitä omaa omaisneuvontaa (on). Et se on paljo selkeempi tarjota, ku tää on oma

omaisneuvonta. Et uskosin, et se on aina helpompi sieltä käsin näin, että muutenhan siinä voi olla just semmonen olo, et otan omaisen ja kysyn miten voi ja sitten ei oikein tiedä, et mitäs mä voin tarjota, jos se on joku ulkopuolinen, mitä meiänki toiminta on, mitä ei ehkä tunne niin hyvin. Niin tuota se selkiyttää, että tietää, että siinä on ne toiselta osastolta olevat ihmiset, ni kyllä he tuntee toisensa. Et ne on siinä omaisneuvonnassa mukana, ni ainahan se helpottaa suosittelemaan omaiselleki, madaltaa sitä kynnystä, ku tiettää, et siellä on se tuttu. (H3.)

Järjestötyön anti psykiatrisen osaston arkeen oli mahdollisuus tarjota järjestön palveluita, mutta hoitajille tuntemattoman palvelun suositteleminen voi olla vaikeaa. Osaston sisäinen palvelu, jossa on tuttuja työntekijöitä muuttaa suhtautumista. Omaista on helpompi huomioida, kun on konkreettista tarjottavaa ja hyvä käsitys tarjottavan palvelun luonteesta ja tekijöistä.

Toiminnanjohtaja painottaa inhimillistä kanssakäymistä tärkeänä osana toimintakulttuurin muutoksen luomista. Hoitajien keskinäinen keskustelu ja kokemusten vertailu tulee esiin voimakkaasti. Huomion arvoista on, että tähän keskusteluun tulee aivan uutta sisältöä omaisneuvonnan kautta, kun omaisten näkökulma avautuu eri tavalla verrattuna normaaliin osastolla tapahtuvaan rutiininomaiseen kohtaamiseen. Muutos tapahtuu kanssakäymisen myötä ruohonjuuritasolla orgaanisesti. Keskustelu avaa omaisnäkökulmaa hoitajien keskuudessa ja kenties kannustaa uusia hoitajia omaisneuvonnan piiriin. Positiivisen kehän syntyessä nämä uudet hoitajat puolestaan alkavat toimia yhä innokkaammin omaisasian puolesta puhujina ja toimintakulttuuria muutetaan asteittain.

Johtoportaan ja esimiesten sitoutumisesta puhuttiin, mutta jäi epäselväksi, kuinka paljon he lopulta panostivat käytännön toteutukseen. Aineiston pohjalta hankkeessa mukana olleet olisivat toivoneet enemmän esimiehiltä:

Hanketyöntekijä: Vaikuttaa tosi paljo aina byrokratia ja muut, että mitenkä ottaudutaan ja annetaan resursseja siihen missä rajoissa pitää tehdä se. (H1.)

Kehittämisasiantuntija: Jos vaan mahollista ni rajaisin kaiken muun työtehtävän pois. Jos on palkattu johonki tiettyyn työtehtävään, ni pitää osata sanoo ei sitte muuhun, että pystyy sen yhen asian hoitamaan kunnolla. Mutta olisin vaatinu enemmän ohjausta, että mitenkä näitten asioiden kanssa edetään oikeesti, että aika yksin hankkeessa sai tätä asiaa pyöritellä. Tosi yksin, että et ite autoin paljo muita, mutta kukaan ei auttanu minuu paitsi tietysti täällä järjestössä oli paljo apuu, mutta että pitää osata vaatia enemmän sitä verkostoo ympärille. (H2.)

Toiminnanjohtaja: Se on kuitenkii hyvä, että he on niin myönteisesti suhtautuneet siihen, että on omaisneuvojien koulutukset voitu järjestää, ja he on myös antanu työaikaa käytettäväksi omaisneuvontaan. Että eihän semmoset oo itsestäänselviä asioita, että ne on resurssikysymyksiä, joihin tehään päätökset jossain. Ja ainahan se voi olla katkolla, että päätetään joku tuleeki joku päivä et tää nyt ei enää satsata tähän asiaan. (H3.)

Suunnittelua varjosti epävarmuus johtoportaan sitoutumisen jatkumisesta. Tämän vuoksi ruohonjuuritason toimintaan panostamalla yritettiin luoda perustuksia toimintakulttuurin muutokselle, joka jatkuisi siinäkin tapauksessa, että virallinen tuki jää pois. Suunnittelua siis tehtiin kahdella eri tasolla, virallisten tavoitteiden mukaisesti sekä käytännön työn tasolla. Ruohonjuuritason työllä ei synny velvoitetta toimia uuden mallin mukaisesti muuten kuin ryhmäpaineen myötä. Ruohonjuuritasolla toimintakulttuuria muutetaan toisin sanoen suurelta osin vapaaehtoisesti, kun esimiesten taholta tuleva määräys toisi virallisen velvoitteen toimia uudella tavalla. Tämän tutkielman yhteydessä ei ole mahdollista vertailla näiden erilaisten motivaation lähteiden vaikutusta tai niiden yhteisvaikutusta. Oletettavasti molemmat motivaation lähteet ovat tehokkaita ja molempia tarvitaan.

5.3 Omaisen kokemuksen ymmärtäminen motivoi toimintakulttuurin muutosta

Tämän tutkielman kannalta hoitajien oppiminen ymmärtämään omaisen kokemusta on olennainen asia. Omaisen kokemus toimintakulttuurin muutoksen motivoijana nousee tutkielmassa

keskeiseksi tekijäksi muistiinpanojen, haastatteluiden ja oman, toimintaa tarkkaillessa saamani kokemuksen perusteella. Omaisen kokemusta käsiteltiin kaikilla hankkeen osa-alueilla eli koulutuksissa, harjoitusten yhteydessä ja kehityspalavereissa. Siitä muodostui Auttava omainen -hankkeen punainen lanka. Usein omaisen kokemuksen ymmärtäminen vaati oivalluksen, jonka ansiosta vanhoja ajatusmalleja kyettiin kyseenalaistamaan. Tätä oivallusta edesauttoivat keskustelu, omaisneuvonnan tekeminen, osallistuminen harjoituksiin ja kokemusasiantuntijan kuuleminen. Toiminnanjohtajan mukaan erityisesti omaisneuvonnassa saatu kokemus auttoi vakuuttamaan omaisasian tärkeydestä, ja omaisneuvojina toimineet olivat hyviä viestinviejiä:

> *Toiminnanjohtaja: Ku he käy omaisneuvontanäkökulmasta keskusteluja ihmisten kanssa niin oon ymmärtäny, että seki sitten valaisee sitä näkökulmaa, että siinä muussaki työssä pystyy huomioimaan. Ja nää kokemusasiantuntijoiden kertomukset niin on siinä ihan hyvä, toivottavasti hyödynnetään silleen, et auttaa ihmisiä. (H3.)*

Salosta vierailemaan tullut kokemusasiantuntija aiheutti vahvan reaktion kuulijoissa puhuessaan erikoissairaanhoidon hoitajille. Minulle tämä reaktio näyttäytyi hyvänä keskustelunavaajana tunnepohjaisuutensa vuoksi. Keskusteluista välittyi oivallus siitä, miten vieras asia omaisen kokemus on ollut arkityössä. Tällainen tunnepohjainen keskustelunavaus voisi toimia hyvänä alustana toimintakulttuurin muutosta rakennettaessa. Kokemusasiantuntijan kertomuksella tyttären itsemurhayritysten synnyttämistä koettelemuksista oli lähes shokeeraava vaikutus ja kohtaamisesta jäi väistämättä muistijälki. Tämä muistijälki auttaa motivoimaan oman toiminnan muuttamista ja vaikuttaa asenteeseen, kun omaisen kohtaamista työympäristössä peilataan kokemusasiantuntijan kokemuksiin. Hyvä esimerkki omaisten henkilökohtaisten kokemusten vaikutuksesta on omaistyöhön FinFamin alueyhdistyksessä tutustunut kehittämisasiantuntija:

> *Kehittämisasiantuntija: Ihan alussa ajatteluun teki käänteentekevän vaikutuksen, ku kävin täällä omaisryhmissä kuuntelemassa näitä omaisten kokemuksia, ni semmonen, että ai hyvänen aika miten paljo on hommaa tän asian eteen vielä tehtävä. Ja siis ei varmaan koskaan saavuteta sitä ihannetilannetta ehkä, mut paljo pystys tekemään*

asioita, et ne olis paremmin ja se sysäs oikeesti viemään eteenpäin tätä et tää on oikeesti tosi tarpeellinen juttu. (H2.)

Rutiininomainen omaisen kohtelu sivuuttaa yhden suuren ongelman mielenterveystyössä. Ongelma ei tule esiin osastolla, koska omainen on siellä läheisensä vuoksi eikä odotakaan apua itselleen. Ongelma paljastuu vasta, kun omainen kohdataan ihmisenä ja kuullaan hänen arjestaan ja läheisen sairastumisen aiheuttamista ongelmista. Kehittämisasiantuntija kuvaa vaikutusta käänteentekeväksi ja tämä vaikutus näkyi vahvasti työotteessa. Kehittämisasiantuntijaan henkilöityy tämän tutkielman ydin. Auttava omainen -hankkeen alussa hän ei oikeastaan vielä tiennyt mihin on ryhtymässä, mutta hankkeen kestäessä hänestä muodostui intohimoinen omaisasian puolustaja, kun omaisten kokemus ja yksilöllisen huomioinnin tarpeellisuus avautuivat järjestöyhteistyön ja hanketyön myötä.

FinFamin mukaan Suomessa on tällä hetkellä lähes puoli miljoonaa mielenterveysomaista. Mielenterveysomaisten määrä on myös kasvussa, sillä psykiatrista hoitoa odottaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut kahden viime vuoden aikana. (FinFami.fi 2022.) Kyseessä on siis suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka ehkäisemiseksi ei ole tehty juurikaan konkreettisia toimia. Järjestötoimijat ovat pienten resurssiensa armoilla, joten yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa halutaan tehdä. Toimintakulttuurin muutosta kaivataan siis jopa yhteiskunnallisella tasolla. Kehittämisasiantuntija mietiskeli asiaa näin:

Kehittämisasiantuntija: Onko se aina näihin mielenterveyspalveluihin ja asioihin liittyvät asiat ni onko ne vähän semmosta, että meiän yhteiskunnassa pyritään painamaan tuonne taka-alalle. Että ei korosteta ja nosteta, et se varmaan näkyy tässäki kohtaa kun on myös omaistyöstä kyse… Kyllähän se jotain tutkimustietoo siitä oli, että esim miten moni jäikään työelämästä pitkälle sairaslomalle, ni se jos lasketaan hintalapuks, ni se on paljo. Ja sitte tossa omaisneuvonnassa oon huomannu sen, että melkein poikkeuksetta kaikki on sairaslomalla ihan melkein kaikki ni kyllähän se kertoo jotain siitä, että ihan äärirajoillahan ihmiset menee tuolla omaisena, omaishoitajana ihan suoraan sanottuna ilman virallista statusta. (H2.)

Toimintakulttuurin muutosta motivoimaan tarvittaisiin vielä enemmän tutkimustietoa mielenterveysomaisten kärsimyksen vaikutuksesta yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen tiedostus helpottaisi stigmaa ja toisi resursseja sekä velvoitetta toimintaan aivan ylimmältä tasolta. Jos mielenterveystyötä ammatikseen tekevät hoitajat eivät tiedä omaisen arjen haasteista, ei voida yhteiskunnallisella tasolla odottaa ainakaan yhtään enempää.

5.4 Auttava omainen -hankkeen arviointi

Tämän tutkielman loppuessa kesällä 2018 Auttava omainen -palvelu ei ollut toiminnassa täysin suunnitelman mukaisesti. Omaisneuvontaa tehtiin, mutta vertaisomainen ei ollut siinä mukana. Vapaaehtoisia omaisia ei yksinkertaisesti saatu mukaan toimintaan, kuten toiminnanjohtaja oli ennustanutkin. Omaisia osallistui koulutuksiin jonkin verran, mutta varsinaista vertaisomaistoimintaa päästiin vain kokeilemaan. Tästä huolimatta hankkeen anti koettiin positiiviseksi. Parantunut yhteistyö Siun soten kanssa toi uskottavuutta FinFamin toimintaan ja siten uusia asiakkaita:

> *Toiminnanjohtaja: Onhan tässä hyvää vuoropuhelua enemmän tullu tän psykiatrian ihmisten ja meiän kesken ja omaisten kesken ja vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoitten… Outokummussa ku oli tää omaisten tietoilta, ni sinnehän on saatu uusi ryhmä. Siellähän ei pitkiin aikoihin oo ollu mitään omaisten ryhmää vuosikausiin, ni nyt tänä keväänä se abc-ryhmä siellä uudestaan ja uusia ihmisiä tullu mukaan. Että ainaki siellä onnistu se yhteistyö, että saatiin näkyvyyttä tälle. Ja voi olla muillaki paikkakunnilla, että se ehkä se näihin ryhmiin tulemiseen on saattanu vaikuttaaki, että ihmiset on tietosempia ja tulevat ja sitten näkevät, että ollaan yhteistyössä Siun soten kanssa, ni ehkä se vahvistaa sitä luottamusta, että tää on asiallinen toiminta. (H3.)*

Toiminnanjohtajan pohdiskelusta nousee esiin näkyvyys, luotettavuus ja uskottavuus. Omaisten tietoiltojen kautta omaistoiminta sai näkyvyyttä ja sitä kautta uusia asiakkaita. Outokummun

omaisryhmän käynnistyminen uudelleen on hyvä näyttö onnistumisesta tässä suhteessa. Järjestötoiminnan linkittyminen julkiseen terveydenhoitoon toi sille uskottavuutta ja toimi siten uudenlaisen luotettavuuden pohjana. Odotukset jatkon suhteen ovat varovaisen optimistiset, aivan kuten suunnittelun alkuvaiheessakin. Auttava omainen -hanke toteutti toiminnanjohtajan sille asettamat minimitavoitteet ja enemmänkin. Toiminnanjohtajan tavoitteethan olivat hyvin varovaiset kokemuksen tuoman hanketyötä koskevan skeptisyyden myötä. Siksi Auttava omainen -hankkeen tuomat edistysaskeleet sekä yhteistyössä terveydenhuoltoon että omaisten huomioinnissa psykiatrisen hoidon yhteydessä olivat toiminnanjohtajalle erittäin hyvä tulos.

Kehittämisasiantuntija koki hankkeen onnistuneen resursseihin nähden hyvin. Parantunut yhteistyö Finfamin ja Siun soten välillä hyödytti molempia organisaatioita. Asetetut tavoitteet (omaisneuvonnan toteuttaminen, uusien toimintamallien juurruttaminen ja omaisten huomioinnin parantuminen käytännön työssä) saatiin täytettyä vapaaehtoisten puuttumisen aiheuttamia rajoitteita lukuun ottamatta. Kehittämisasiantuntija koki, että omaisasian tiedostamisessa oli havaittavissa konkreettinen muutos:

> *Kehittämisasiantuntija: Kyllä mie oon tyytyväinen, että totta kai aina voi onnistuu paremminki. Mut ei tää ihan puihinkaan menny, ei todella, että FinFamin kanssa yhteistyö pelas niin hyvin, että yhessä myö saatiin tää rykästyy läpi… Mutta se, että meillä on nyt omaisneuvontaa tuossa, ollaan tietosempia FinFamin toiminnasta tuolla, ohjataan tänne (FinFamille). Siitä on molemminpuolista hyötyy sitten. Tietosuus on lisääntyny ihan selvästi, on toimintamalleja juurtunu elikä nää omaisneuvontapalaverit, tietoiltoja on täältä FinFamilta käsin lähetty yhteistyössä järjestämään, se on tosi hienoo. (H2.)*

Kehittämisasiantuntija korostaa yhteistyön molemminpuolista hyötyä ja uskoo toiminnan jatkuvuuteen. Hoitajat osasivat ohjata omaisia paremmin FinFamin palveluiden piiriin, ja erikoissairaanhoitoon oli juurtunut uusia toimintamalleja, kuten omaisneuvontapalaverit ja tietoillat. Kehittämisasiantuntijan sitoutuneisuus toiminnan jatkumiseen oli ratkaiseva tekijä hankkeen on-

nistumisen kannalta. Uuden toimintakulttuurin juurruttaminen vaatii sinnikkyyttä, jota kehittämisasiantuntijalta löytyi runsain mitoin. Vastuu Auttava omainen -hankkeen käytännön vaikutuksesta jäi pääosin hänen harteilleen, mutta omaisasian vaikuttavuus oli hänen puolellaan ja tukijoukkoja löytyi sanan levittämiseen. Kehittämisasiantuntija koki toimintakulttuurin muutoksen niin tärkeäksi, että otti asiakseen liittää sen uusien hoitajien perehdytykseen:

> *Kehittämisasiantuntija: Opiskelijoiden perehdytykseen aion lisätä omaisasian, et sitä ei oo ollu siellä ja en tiiä minkälaista työntekijöiden perehdytys, ni siellä ois hyvä olla mukana varsinki ku uus työntekijä, ni mitä on omaisneuvonta ja mikä on omaisyhistys ja mitä on tärkeetä ottaa huomioon omaisten suhteen. Muistaakseni joillaki opiskelijoilla on ollu, ni heille kuulu jossain vaiheessa keskustelu omaisen kanssa. Ihan tosi moni pelkäs sitä, ja se on varmaan ihan totta, että ehkä itsekin vastavalmistuneena hoitajana saatoin pikkasen pelätäki omaisia. (H2.)*

Hoitohenkilökunnan asenteiden muokkaus jo perehdytysvaiheessa on tietenkin tehokkaampaa kuin rutiinien murtaminen ja uudistaminen. Myös perehdytyksen yhteydessä korostuu päättävän tahon vastuu omaisen aseman parantamisesta. Ongelman tunnistaminen ja oikea lähestymistapa on avainasemassa, jos osoittautuu, että perhekeskeisen hoitotavan yhteydessä ei kyetä huomioimaan omaista yksilönä.

Haastatteluissa selvitettiin Auttava omainen -hankkeen arvopohjaa työryhmän kokemana. Esiin tuli perusarvoja, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, eettisyys ja yhteisöllisyys. Arvoja ei työtä tehtäessä erityisesti mietitty, mutta toiminnanjohtajalle asia näyttäytyi omaislähtöisen toimintatavan eri muotojen kehittämisenä. Omaisten huomioiminen itsessään arvokkaana asiana yhteistyössä terveydenhuollon kanssa löytyy keskustelun ja toiminnan kautta:

> *Toiminnanjohtaja: Ei varmaan kyllä mietitty mitään erikoisesti arvoja, että ollaan jollain erityisellä arvopohjalla, mutta varmaan meiän näkökulmasta ne arvot on se omaislähtöisyys ja sellanen sen eteenpäin vieminen. Omaisten asian, hyvinvointiin liittyvät asiat, et niitten eteenpäin vieminen yhteistyössä. Ja et sellanen en tiiä voiko*

> *sitä arvoks sanoo, mut sellanen, että omaisen huomioiminen semmosena itsessään arvokkaana asiana, niin varmaan se on se, miltä meiän puolelta lähetään liikkeelle siinä. (H3.)*

Omaisen huomioiminen itsessään arvokkaana asiana tiivistää toiminnanjohtajan filosofian omaistyössä. Tässäkin yhteydessä esiin nousee yhteistyön merkitys. Jatkuva keskusteluyhteys antaa mahdollisuuden jatkaa omaisasian edistämistä terveydenhuollon piirissä, vaikka Auttava omainen -hankkeen yhteydessä suunnitellut konkreettiset toiminnot eivät jatkuisikaan. Kaikki työryhmän jäsenet korostivat vahvasti omaisen etua kantavana voimana suunnittelussa. Toiminnanjohtaja huomio siitä, ettei omaisten huomioiminen ole lakisääteinen asia kertoo siitä, että omaisasia ei perustu sääntöihin vaan ihmisten käytännön toimintaan.

Analyysi on hyvä lopettaa Auttava omainen -hankkeen tuomiin oppeihin. Hanketyöntekijä koki oppineensa aikataulutusta, kirjoittamisprosessin suunnittelua, yhteistyötaitoja ja itsearviointia. Toiminnanjohtajan aikaisempi kokemus oli niin vahva, että suuria yllätyksiä ei hänelle tullut. Hän osasi asettaa odotukset realistisesti, ellei suorastaan pessimistisesti. Niinpä työn saavutukset olivat hänelle positiivinen yllätys. Suurimmat opit tulivat vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä:

> *Toiminnanjohtaja: Tässä on joutunu enemmän perehtymään siihen vapaaehtoistoiminnan asioihin kyllä ja sitä puolta miettimään, että minkälainen se vapaaehtoistoiminta on. Että minkä tyyppisiä ihmisiä siihen pystys ees lähtee mukaan ja millä edellytyksillä ja miten se vois ees mahollisesti toimii, nii siihen puoleen tässä on ihan oma, koska täällä ei ennen vertaistukitoimintaa ole ollu. (H3.)*

Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen pienellä paikkakunnalla vaatii siis enemmän suunnittelua ja oikeiden ihmistyyppien tunnistamista. Pienet resurssit ja vapaaehtoisten määrä asettavat toiminnalle haasteen toimia mahdollisimman tehokkaasti. Pelkästään tiedon välitys omaisille on vaikeaa puhumattakaan vapaaehtoiseksi aktivoimisesta. Toiminnanjohtaja osasi ennakoida ongelman, ja se muokkasi hänen odotuksiaan realistisempaan suuntaan.

Kehittämisasiantuntijalla ei ollut toiminnanjohtajan kokemusta, joten hänen odotuksensa eivät vastanneet realiteetteja kaikilta osin. Hänelle Auttava omainen -hanke toikin oppia monilla eri tasoilla, niin hoitotyön ammattilaisena, hanketyön vetäjänä, yhteistyön kehittäjänä ja sanansaattajana, ehkä jopa ihmisenä:

> *Kehittämisasiantuntija: Hirveen tärkeetä on se aikataulutus ja selkee tuki hanketyöntekijälle, mitä tehään ja mitä odotetaan. Ainaki ite koen tärkeeks, vaikka pitää olla semmonen itsesä johtamistaito tämmösessä, mutta selkeyttä kyllä vaatii…*
> *Se on semmosta vellovaa aaltoliikettä, välillä vähä taka-askelia ja välillä taas mennään eteenpäin. Ja että on just oppinu sitä semmosta, et mikä on olennaista ja mikä epäolennaista. Ja kannattaa paljo ihmisiä osallistaa siihen, jotka jättää sitä toimintamallia elämään, että jos tästä nyt vaikka lähtiskii toiselle töihin ni siellä tää homma kyllä jatkuu. Et tää homma ei oo yhen ihmisen varassa, et se on välillä ollu liikaaki sairaalan puolella oman itseni varassa, että liikaa laitto omaa päätä pölkylle siinä, et varmasti saahaan homma eteenpäin. (H2.)*

Kehittämisasiantuntijalle Auttava omainen -hanke oli kasvattava kokemus, jonka myötä hanketyön realiteetit selvisivät. Hanketyö elää jatkuvasti, joten se vaatii tekijöiltä joustoa. Toisaalta on osattava myös vaatia tukea, jos sitä ei saakaan odotetulla tavalla. Kehittämisasiantuntijan kokemus oman vastuun merkityksestä kertoo onnistumisen olleen pitkälti hänen varassaan. Siksi hän korostaakin osallistamisen tärkeyttä Auttava omainen -hankkeen jatkuvuuden kannalta. Mitä enemmän ihmisiä vakuuttuu omaisasian tärkeydestä, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on jäädä pysyväksi osaksi erikoissairaanhoidon arkea. Pieni hanketyö kehittyi psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintakulttuurin muutokseen tähtääväksi työksi, jota ajoi tekijöiden omistautuminen asialle.

6 Tutkielman tulokset ja loppupohdinta

Kahden organisaation edustajien muodostama pieni yksikkö näyttäytyi lähes itsenäisenä toimijana, joka kehitti omat toimintatapansa ja pyrki niiden kautta toteuttamaan tavoitteitaan. Siun soten osalta kysymyksessä oli hyvin pieni projekti, ja se henkilöityi vahvasti sitä johtamaan määrättyyn henkilöön. Hän toimi arkityössään mielenterveyshoitajana, joten hänen alkuasenteensa oli hoitokäytäntöjen ja -rutiinien muodostama. Tämä henkilö oli avain sekä Auttava omainen -hankkeen kehittymiseen että tämän tutkielman tärkeimpien näkökulmien avautumiseen.

Toimiessaan Auttava omainen -hankkeen johtohahmona hän otti harteilleen suuremman vastuun kuin alussa osasi aavistaakaan, koska uudet näkökulmat toivat hänelle jopa moraalisen velvoitteen ajaa omaisten asemaa tavoilla, jotka eivät alussa olleet näkyvissä. Näistä tavoista tärkeimmäksi muodostui psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintakulttuuriin vaikuttaminen, kun vapaaehtoisten puutteessa Auttava omainen -hanke jäi palvelun muodossa vajaaksi. Toimintakulttuurin muuttaminen näin vähäisin resurssein osoittautui haasteelliseksi, mutta siihen pyrittiin pitkäjänteisesti ja hyvin motivoituneesti. Auttava omainen -hankkeen suunnitteleminen avasi väylän yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa, mitä FinFamin alueyhdistys oli kaivannut. Suunnittelu ja järjestöyhteistyö avasivat uusia näkökulmia mukana olleille hoitohenkilökunnan edustajille, mikä vaikutti olennaisesti heidän motivaatioonsa ajaa omaisten asiaa.

Omaisten kokemus toimi ensisijaisena vaikuttimena uusien näkökulmien avautumiselle hoitajien keskuudessa. Toimintakulttuurin muutoksen avain tuntuu olevan tunnepohjaisen reaktion aikaansaaminen. Tunnepohjaisen reaktion tuottamiseen vaaditaan ulkopuolinen tekijä, joka rikkoo tottumuksen tuottamia ajatusmalleja ja rutiineja. Tämä ulkopuolinen tekijä voi olla esimerkiksi kokemusasiantuntija, työskentely omaisneuvonnassa tai hyvin järjestetty koulutus sekä tietenkin näiden yhdistelmä.

Toimintakulttuurin muutoksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin sitkeää päivittäistä työtä ja vahvaa johtoportaan tukea. Myös esimiesasemassa olevia henkilöitä tulisi altistaa omaisten kokemuksille mahdollisuuksien mukaan. Vanhat toimintamallit eivät muutu yhden oivalluksen myötä, mutta se voi antaa mahdollisuuden nähdä omainen ei vain tiedonantajana vaan ihmisenä. Jos tähän oivallukseen yhdistetään työpaikkakulttuuriin soveltuvat mallit omaisen huomioinnin parantamiseksi, saadaan aikaan yhdistelmä, joka voi tuottaa toimintakulttuurin muutoksen.

Perhekeskeinen hoitomalli on ongelmallinen tämän tutkielman ja oman kokemukseni perusteella. Ajatus on hyvä, mutta käytännössä toteutus ei tunnu huomioivan omaista yksilönä. Esimerkiksi FinFami pitää perhekeskeistä lähestymistapaa tärkeänä uudistuksena mielenterveystyössä, mutta jos perhekeskeisen hoitotavan arki ei vastaa sen kuvausta niin puhutaan eri asioista teoriassa ja käytännössä. Omaisen kannalta ei ole merkitystä millä termillä hoitotapaa kuvataan, jos rooliksi jää tiedonantajan osa joka tapauksessa.

Puhuttaessa perheestä ei yksilö välttämättä nouse esiin. Näyttää siltä, että perhekeskeisyys on hyvin tulkinnanvarainen käsite, jonka merkitys todennäköisesti vaihtelee työympäristöjen välillä. Jos perhekeskeisyyden määritelmä elää, täytyisi ensin analysoida kaikki sen ottamat muodot oikeiden kysymysten selvittämiseksi. Vasta oikeita kysymyksiä esittämällä päästään käsiksi omaisen ja hoitohenkilökunnan kokemukseen asiasta. Ei ole vaikea kuvitella kuinka epämääräisenä perhekeskeisyys näyttäytyy omaiselle, jos hoitohenkilökunnallakin on vaikeuksia sen määrittelemisessä.

Tämän tutkielman tulokset voi tiivistää toimintakulttuurin muutoksen osalta kolmeen kohtaan:

1. Toimintakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä, jonka motivoimiseksi on suositeltavaa yrittää luoda tunnepohjainen side.
2. Tunnepohjaisen siteen muodostamiseksi kokemusasiantuntijan tai omaisen kuunteleminen on tehokas keino, jota voidaan käyttää sekä koulutuksissa että omaisneuvontatyöhön kannustamalla.
3. Toimintakulttuuria voidaan muuttaa useammalla eri tasolla samanaikaisesti. Esimiesten sitoutuminen ja aktiivinen panos sekä käytännön työssä että koulutuksessa on tärkeää,

> mutta kenties vielä merkityksellisempää voi olla ruohonjuuritason työ, joka tuottaa vapaaehtoisen toiminnan kautta motivaation toimintakulttuurin muuttamiseen.

Toimintakulttuurin muutoksen onnistuminen riippuu monesta tekijästä, eikä välimuotoa välttämättä ole. Pysyvien toimintamallien juurtuminen edellyttää jatkuvaa motivaation uudistamista ja työtapojen toistamista niin johdon kuin henkilöstönkin osalta. Uudet toimintamallit voivat hiipua olemattomiin muutokseen positiivisesti suhtautuvien työntekijöiden jäädessä vähemmistöksi. Tämä ilmiö oli jo havaittavissa tämän tutkielman seurantajakson loppuvaiheessa. Akabas, James & Mandiberg (2010) ja Edwards ym. (2013) ovat päätyneet samankaltaisiin tuloksiin omissa vertaistoimintaa koskevissa tutkimuksissaan. Heidän mukaansa muutoksen pysyvyys vaatii johdonmukaista uusien toimintamallien sisäänajoa, missä esimiehet ovat avainroolissa. Uudet toimintamallit sisäistetään, kun niille kehitetään arjessa toistuvat käytännöt ja niiden vaikutus kaikkien osallisten rooleihin huomioidaan. (Akabas ym. 2010, 152; Edwards ym. 2013, 12.)

Ashforth & Humphrey (1995) ovat kirjoittaneet tunteiden merkityksestä organisaation toiminnassa. Tunteita on aliarvioitu työmotivaation perustana, joten niitä on pyritty säätelemään sen sijaan että niitä hyödynnettäisiin. Työlle omistaudutaan ainoastaan tunneyhteyden syntyessä, ja tunteet voivat käynnistää joukkoreaktion levitessään työyhteisössä. (Ashforth & Humphrey 1995, 119–120.) Lisää tunteiden merkityksestä organisaatiossa: katso esimerkiksi Amichai-Hamburger & Fox (2001), Fisher (2002), Bindl (2019) ja Kamran-Morley & Lebel (2021).

Tein pro gradu -tutkielmani aineistolähtöisesti, mutta oma kokemukseni vaikutti taustalla. Harkitsin huolellisesti oman kokemukseni merkitystä tutkielman eri vaiheisiin ja pyrin suhtautumaan siihen ikään kuin tutkimusaineistoon. Uskon kokemukseni olleen hyödyllinen lisä tutkielman tekemisessä, koska pystyin sen avulla tuomaan omaisen näkökulmaa esiin enemmän ja minulla oli tutkielman aihepiiriin liittyvää tietoa paljon jo ennestään. Tutkielman kannalta tärkein henkilö oli kuitenkin kehittämisasiantuntija, jonka toiminta oli avain sekä Auttava omainen -hankkeen onnistumiseen että tutkielman näkökulmien kehittymiseen. Kehittämisasiantuntijan tutustuminen omaisen kokemukseen ja siitä seurannut työote ja omaisasian ajaminen hoitajien keskuudessa olivat olennaisia tekijöitä tutkielmassani. Haluan vielä korostaa, että tarkoitukseni ei missään tapauksessa ole arvostella yksittäisten hoitajien toimintaa.

Tutkielmani on hyvin pienimuotoinen, eikä siitä voi tehdä pitäviä yleistyksiä. Jatkotutkimusta lähtisin tekemään avaamalla sekä hoitohenkilökunnan että omaisten kokemuksia perhekeskeisestä hoitotavasta. Oikeita kysymyksiä esittämällä perhekeskeisen hoitotavan toimivuutta ja merkityksiä voisi analysoida uudesta näkökulmasta. Vertailun vuoksi perhekeskeisen hoitotavan käytäntöihin tulisi tutustua useammalla eri paikkakunnalla. Samalla olisi mahdollisuus tutkia omaisen henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä ja sen ymmärtämistä eri yhteyksissä. Lisäksi jatkotutkimus voisi antaa työkaluja tunnepohjaisen siteen luomiseen psykiatrisen erikoissairaanhoidon omaistyössä.

Lähteet

Akabas, Sheila H. & Gates, Lauren B. & Mandiberg, James M. (2010) Building Capacity in Social Service Agencies to Employ Peer Providers. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 34(2), 145–152. [Viitattu 2.3.2023] https://doi.org/10.2975/34.2.2010.145.152

Alami, Sophie (2014) Opportunity & Challenge in the Health Care Industry: Anthropological Inroads in France. Teoksessa Rita Mary Taylor Denny & Patricia L. Sunderland (toim.) *Handbook of Anthropology in Business*. Walnut Creek, California: Left Coast Press, 234–246.

Amichai-Hamburger, Yair & Fox, Shaul (2001) The Power of Emotional Appeals in Promoting Organizational Change Programs [and Executive Commentary]. *Academy of Management Perspectives*, 15(4), 84–95. [Viitattu 5.3.2023] https://doi.org/10.5465/ame.2001.5897664

Ashforth, Blake E. & Humphrey, Ronald H. (1995) Emotion in the Workplace: A Reappraisal. *Human Relations (New York)*, 48(2), 97–125. [Viitattu 4.3.2023] https://doi.org/10.1177/001872679504800201

AVOT -hankesuunnitelma (2016) *AVOT – Siun sote: Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla -hankesuunnitelma*. [Viitattu 3.2.2023] https://web.archive.org/web/20230327111401/https://www.siunsote.fi/documents/393252/5183861/Hankesuunnitelma_AVOT_310816.pdf/13638773-8915-4aa8-a3ec-bf9c6cfa33ce

Barrett, Michael & Gibson, Sarah & Gillard, Steve & Oborn, Eivor (2019) Knowledge and expertise in care practices: the role of the peer worker in mental health teams. *Sociology of Health & Illness*, 41(7), 1305–1322. [Viitattu 24.2.2023] https://doi.org/10.1111/1467-9566.12944

Basset, Thurstine & Faulkner, Alison (2012) A helping hand: taking peer support into the 21st century. *Mental Health and Social Inclusion*, 16(1), 41–47. [Viitattu 23.2.2023] https://doi.org/10.1108/20428301211205892

Bindl, Uta K. (2019) Work-related proactivity through the lens of narrative: Investigating emotional journeys in the process of making things happen. *Human Relations (New York)*, 72(4), 615–645. [Viitattu 4.3.2023] https://doi.org/10.1177/0018726718778086

Blomberg, Jeanette, & Darrah, Chuck (2015) Towards an Anthropology of Services. *The Design Journal*, 18(2), 171–192. [Viitattu 2.3.2023] https://doi.org/10.2752/175630615X14212498964196

Bochicchio, Lauren & Cabassa, Leopoldo & Collins-Anderson, Akilah & Stefancic, Ana & Tuda, Daniela (2022) "Getting the Staff to Understand It:" Leadership Perspectives on Peer Specialists Before and After the Implementation of a Peer-Delivered Healthy Lifestyle Intervention. *Community Mental Health Journal*. [Viitattu 26.2.2023] https://doi.org/10.1007/s10597-022-01074-x

Bryant, Antony (2017) *Grounded theory and grounded theorizing: pragmatism in research practice*. New York, NY: Oxford University Press.

Carter, Tim & Repper, Julie (2011) A review of the literature on peer support in mental health services. *Journal of Mental Health*, 20(4), 392–411. [Viitattu 24.2.2023] https://doi.org/10.3109/09638237.2011.583947

Charmaz, Kathy (2017) The Power of Constructivist Grounded Theory for Critical Inquiry. *Qualitative inquiry*, 23(1), 34–45. [Viitattu 1.11.2022] https://doi.org/10.1177%2F1077800416657105

Chester, Polly & Crompton, David & Ehrlich, Carolyn & Slattery, Maddy & Vilic, Gabrielle (2020) What happens when peer support workers are introduced as members of community-based clinical mental health service delivery teams: a qualitative study. *Journal of Interprofessional Care*, 34(1), 107–115. [Viitattu 24.2.2023] https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1612334

David, Matthew & Sutton, Carole D. (2011) *Social research: An introduction*. 2. painos. Los Angeles (Calif.): SAGE.

Davies, Charlotte Aull (1999) *Reflexive ethnography: a guide to researching selves and others*. London: Routledge.

Doughty, Carolyn & Scott, Anne (2012) "Confronted with paperwork": Information and documentation in peer support. *Journal of Mental Health (Abingdon, England)*, 21(2), 154–164. [Viitattu 23.2.2023] https://doi.org/10.3109/09638237.2011.638002

Edwards, Christine & Gillard, Steve G. & Gibson, Sarah L. & Owen, Katherine & Wright, Christine (2013) Introducing peer worker roles into UK mental health service teams: A qualitative analysis of the organisational benefits and challenges. *BMC Health Services Research,* 13(1), 1–13. [Viitattu 23.2.2023] https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-188

FinFami.fi (2022) *Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami*. [Viitattu 3.2.2023] https://web.archive.org/web/20230327112541/https://finfami.fi/ajankohtaista/perheita-uhkaa-vakava-terveysriski-joka-voidaan-valttaa/

Fisher, Cynthia D. (2002) Real Time Affect at Work: A Neglected Phenomenon in Organisational Behaviour. *Australian Journal of Management*, 27(1_suppl), 1–10. [Viitattu 4.3.2023] https://doi.org/10.1177/031289620202701S01

Foster, Rhiannon & Gibson, Sarah & Gillard, Steve & Goldsmith, Lucy & Marks, Jacqueline & White, Sarah (2017) Describing a principles-based approach to developing and evaluating peer worker roles as peer support moves into mainstream mental health services. *Mental Health and Social Inclusion*, 21(3), 133–143. [Viitattu 23.2.2023] https://doi.org/10.1108/MHSI-03-2017-0016

Gunn, Wendy & Løgstrup, Louise B. (2014) Participant observation, anthropology methodology and design anthropology research inquiry. *Arts and Humanities in Higher Education*, 13(4), 428–442. [Viitattu 5.3.2023] https://doi.org/10.1177/1474022214543874

Gunn, Wendy & Ventura, Jonathan (2017) Now You See Me, Now You Don't. *Anthropology in Action*, 24(3), 45-55. [Viitattu 23.9.2022] https://doi.org/10.3167/aia.2017.240305

Hyvärinen, Jaana & Lee, Jung-Joo & Mattelmäki, Tuuli (2015) Fragile Liaisons: Challenges in Cross-organizational Service Networks and the Role of Design. *The Design Journal*, 18(2), 249–268. [Viitattu 22.12.2022] https://doi.org/10.2752/175630615X14212498964358

Impilä, Mirka & Pajunen, Sanna-Maria (2018) *Auttava omainen-toiminnan juurtuminen psykiatriseen hoitotyöhön -hoitohenkilökunnan näkökulma.* AMK-opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.2.2023] https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/153850/impila_mirka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jenkins, Janis (2015) *Extraordinary Conditions. Culture and Experience in Mental Illness.* Oakland: University of California Press.

Johnson, Ginger A. & Pfister, Anne E. & Vindrola-Padros, Cecilia (2015) The role of anthropology in improving services for children and families: An introduction. *Annals of Anthropological Practice*, 39(2), 89–95. [Viitattu 5.3.2023] https://doi.org/10.1111/napa.12073

Jokinen, Arja (2012) Kategoriat, instituutiot ja sosiaalisen järjestyksen tuottaminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) *Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin*. Tampere: Vastapaino, 227–266.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin juuret. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) *Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin*. Tampere: Vastapaino, 17–43.

Jones, Nev & Rosen, Cherise & Teague, Gregory B. & Wolf, Jessica (2020) Organizational Climate and Support Among Peer Specialists Working in Peer-Run, Hybrid and Conventional Mental

Health Settings. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 47(1), 150–167. [Viitattu 26.2.2023] https://doi.org/10.1007/s10488-019-00980-9

Juhila, Kirsi (2012) Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen (toim.) *Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin*. Tampere: Vastapaino, 175–226.

Kamran-Morley, Daniya & Lebel, R. David (2021) Igniting Initiative: Clarifying the Conceptualization of the Energized-to Pathway of Proactivity. Teoksessa Kelly Z. Wong & Chia-Huei Wu (toim.) *Emotion and Proactivity at Work*. Bristol, UK: Bristol University Press, 55–76. [Viitattu 4.3.2023] https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64096

Kinnunen, Anna (2020) *Johtolankoja hulluuteen: tutkimus mielen sairastamiseen kytkeytyvistä kulttuurisista käsityksistä*. Joensuu: SKTS.

Marcus, George E. (1998) *Ethnography through thick and thin*. Princeton (NJ): Princeton University Press.

Nyman, Markku & Stengård, Eija (2001) *Mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointi*. Helsinki: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto.

Nyman, Markku & Stengård, Eija (2005) *Hiljaiset vastuunkantajat. Omaisten hyvinvointi 2001–2004*. Helsinki: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto.

Ojanen, Anette & Tölkkö, Lena (2016) *Vertaisneuvojan ja sote-ammattilaisen yhteistyö omaisneuvonnassa*. AMK-opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.2.2023] https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117271/VERTAISNEUVOJAN%20JA%20SOTE-AMMATTILAISEN%20YHTEISTYO%20OMAISNEUVONNASSA.pdf?sequence=1

Otto, Ton & Smith, Rachel C. (2013) Design anthropology: A Distinct Style of Knowing. Teoksessa Wendy Gunn & Ton Otto & Rachel C. Smith (toim.) *Design anthropology: Theory and practice*. London, UK; New York, NY, USA: Bloomsbury Academic, 1–29.

Poikkimäki, Jussi & Salminen, Janne (2014) *Vertaistuellisen omaisneuvonnan vaikuttavuus omaisen hyvinvointiin*. AMK-opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.2.2023] https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81718/poikkimaki_jussi_salminen_janne.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Psathas, George (1999) Studying the Organization in Action: Membership Categorization and Interaction Analysis. *Human Studies*, 22(2/4), 139–162. [Viitattu 5.3.2023] https://doi.org/10.1023/A:1005422932589

Schein, Edgar H. & Schein, Peter A. (2017) *Organization Culture and Leadership*. 5. painos. Hoboken, New Jersey: Wiley. [Viitattu 11.3. 2023] https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.uef.fi:2443/lib/uef-ebooks/detail.action?docID=4766585

Stengård, Eija (2005) *Journey of Hope and Despair. The Short-term Outcome in Schizophrenia and the Experiences of Caregivers of People with Severe Mental Disorder.* Tampere: Tampere university press.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990) *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. 2. painos. Newbury Park, Calif: Sage.

Tahvanainen, Matti (2017) *"Toisen elämää ei voi elää" Mielenterveysomaisten kokemuksia*. Julkaisematon kulttuuriantropologian kandidaatin tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Kulttuurintutkimus.

Tuohela, Kirsi (2012) Mitä on melankolia? Psyykkinen sairastaminen kulttuurihistorian näkökulmasta. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi (toim.) *Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen*. Turku: Turun yliopisto, 58–82.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) *Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi).* [Viitattu 15.1.2023] https://web.archive.org/web/20230327113632/https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Vakimo, Sinikka (2010) Periaatteista eettiseen toimijuuteen – tutkimusetiikka kulttuurintutkimuksessa. Teoksessa Helmi Järviluoma & Jyrki Pöysä & Sinikka Vakimo (toim.) *Vaeltavat metodit*. Joensuu: SKTS, 79–113.

Whitley, Rob (2014) Beyond Critique: Rethinking Roles for the Anthropology of Mental Health. *Culture, Medicine, and Psychiatry* 38:3, 499–511. [Viitattu 25.1.2023] https://doi.org/10.1007/s11013-014-9382-y

Zimmerman, Don H. (1998) Identity, Context and Interaction. Teoksessa Charles Antaki & Sue Widdicombe (toim.) *Identities in talk*. London: SAGE Publications, 87–106. [Viitattu 12.3.2023] https://doi.org/10.4135/9781446216958.n6

Liiteluettelo

Liite 1: Auttava Omainen -toimintamalli

Liite 2: Aineistoluettelo

Liite 3: Tietosuojaseloste

Liite 1: Auttava Omainen -toimintamalli

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset –FinFami ry

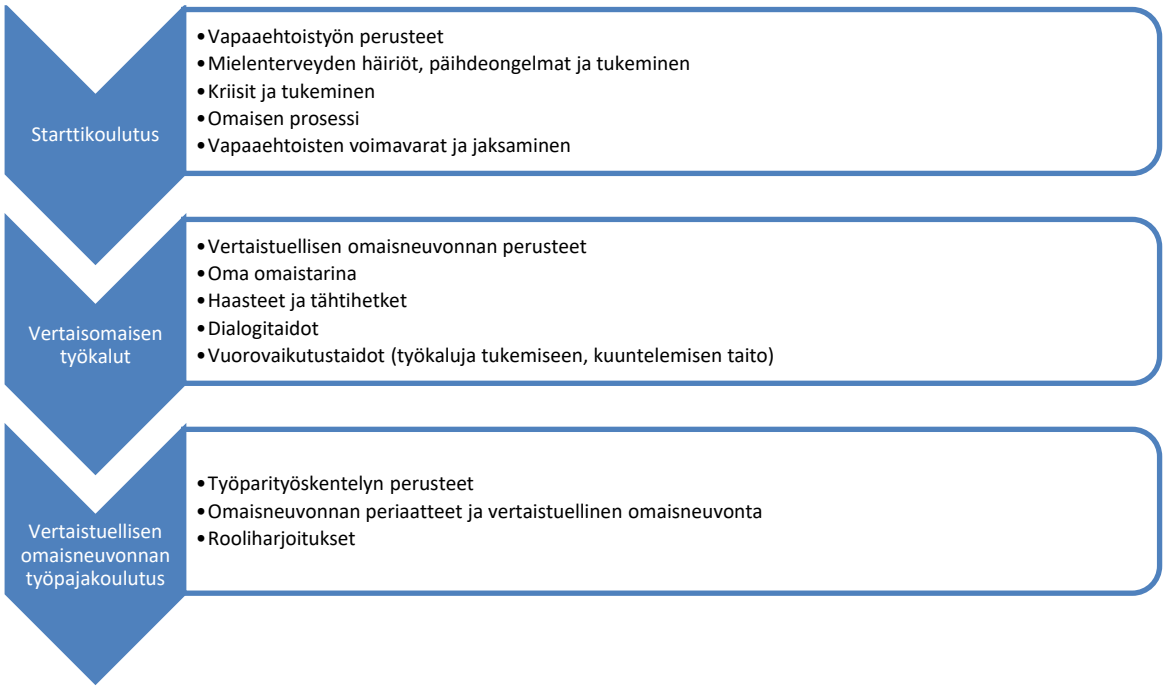
Auttava Omainen –toimintamalli

Auttava Omainen –toimintamallin tavoitteena on, että perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa henkilökunta tunnistaa ja huomioi omaisen tuen tarpeen ja hyödyntää vertaistukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ohjaa omaisia tuen piiriin. Päämääränä on myös juurruttaa vertaistuellinen omaisneuvonta yhteistyötahoihin ja yhdistyksiin, ja kouluttaa henkilökuntaa sekä omaisia vertaisten kanssa toteutettavaan työparityöskentelyyn.

Koulutuksen sisältö

Vertaisomaisten koulutus koostuu Auttava Omainen –koulutusmallin mukaisesti kolmesta osasta: starttikoulutus, vertaisomaisen työkalut ja vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutus. Starttikoulutus on yhteinen FinFamin muiden vapaaehtoisten kanssa. **Sosiaali- ja terveysalan –ammattilaisten koulutus** on kaksiosainen: mielenterveysomaistyön koulutus ja vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutus, joka on yhteinen vertaisomaisille ja ammattilaisille.

Vertaisomaisten koulutus etenee seuraavasti:



Mielenterveysomaistyön koulutus sosiaali- ja terveystyön ammattilaisille:

- Omaistyön tärkeys psykiatriassa ja mielenterveysomaisten tukemisen valtakunnalliset linjaukset
- Yhdistysesittely
- Ajankohtaista tutkimustietoa vertaistuesta ja omaisen jaksamisesta
- Omaisen prosessi, vertaistuellinen omaisneuvonta ja kokemuspuheenvuoro

Liite 2: Aineistoluettelo

Primaariaineisto:
Haastattelu 1, hanketyöntekijä: H1. 5/2018, 6 sivua litteroitua tekstiä.
Haastattelu 2, kehittämisasiantuntija: H2. 5/2018, 16 sivua litteroitua tekstiä.
Haastattelu 3, toiminnanjohtaja: H3. 5/2018, 11 sivua litteroitua tekstiä.
Muistiinpanot, ei viitattu tekstissä. 2017/2018, 7 sivua tekstiä.

Sekundaariaineisto:
Auttava omainen -hankkeen viralliset ja epäviralliset suunnittelu- ja koulutusmateriaalit ja arviointikeskustelut, noin 20 sivua.

Aineisto on ollut koko tutkielman keston ajan minun hallussani varastoituna henkilökohtaiselle tietokoneelleni sekä henkilökohtaiseen, yliopiston tarjoamaan pilvipalveluun. Aineistoa ei ole jaettu eikä näytetty muille. Tutkielman valmistuttua aineisto tuhotaan.

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispvm: 15.3.2023

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Informointivelvoitteesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artikloissa 12–14 ja käsittelytoimista tehtävästä selosteesta artiklassa 30.

Tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittely ja sillä osoitetaan, että tutkimuksessa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaseloste voi toimia myös pohjana tutkittaville annettavan informaation laatimiseen.

1. Tutkimuksen nimi

Auttava omainen – Tutkielma mielenterveysomaisille suunnatun uuden palvelun kehityshankkeesta

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

☐ Täydentävän rahoituksen sopimustutkimus/hanke.

Itä-Suomen yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, puhelinvaihde 0294 45 1111, sähköposti: kirjaamo@uef.fi

☐ Perusrahalla tai henkilökohtaisella apurahalla tehtävä tutkimus

[Tutkija tai tutkimusryhmä on rekisterinpitäjä, jos tutkimusta tehdään perusrahalla tai tutkijan henkilökohtaisella apurahalla siten, että kyseessä ei ole yliopiston sopimustutkimus, ei tehdä oikeuksiensiirtoja ja tutkija/tutkimusryhmä omistaa tutkimusdatan. Kirjaa tähän tutkijan/tutkimusryhmän nimi ja yhteystiedot]

☒ Opinnäytetyö (kandidaatti- tai pro gradu -tutkielma, väitöskirja)

Matti Tahvanainen, 040 8324511, matti_tahvanainen@yahoo.com

☐ Yhteisrekisterinpitäjyys

[Jos kaksi tai useampi rekisterinpitäjä yhdessä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, on kyseessä yhteisrekisterinpitäjyys. Kirjaa tähän yhteisrekisterinpitäjien nimet ja yhteystiedot.]

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kohdassa 2 nimetty rekisterinpitäjä vastaa tutkimuksen suorittamisesta.

4. Tutkimuksen ohjaaja, vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimus on opinnäytetyö, jonka ohjaajana toimii professori Tuulikki Kurki.

5. Tutkimuksen suorittajat

Päävastuullinen tutkija on kohdassa 2 nimetty rekisterinpitäjä.

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tutkimukselle ei nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

7. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Ks. kohta 2.

8. Tutkimuksen luonne

☒ Kertatutkimus ☐ Seurantatutkimus

9. Tutkimusaineiston säilyttäminen, hävittäminen tai arkistointi

Tutkimusaineiston säilytysaika tutkimustarkoituksessa (käyttötarkoituksen mukainen säilytysaika):
5/2018-5/2023

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:

- ☒ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään
- ☐ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan
  - ☐ ilman tunnistetietoja
  - ☐ tunnistetiedoin

Jos tutkimusaineisto arkistoidaan, niin mikä on arkistointipaikka:

[Kirjaa tähän arkistointipaikka, jos tutkimusaineisto on tarkoitus arkistoida tutkimuksen päättymisen jälkeen. Arkistointi tarkoittaa pysyvää säilyttämistä]

10. Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Pro gradu -tutkielmani tarkoitus oli tutkia mielenterveysomaisille tarkoitetun uuden palvelun suunnittelua ja toteutusta. Tutkielman keskiöön nousi hanketyöryhmän pyrkimys muuttaa toimintakulttuuria psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoilla.

11. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on:

- ☒ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin:
  - ☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
  - ☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
  - ☐ yleisen edun mukaisen viranomaistehtävän suorittaminen
- ☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

mikä oikeutettu etu on kyseessä:

☐ rekisteröidyn suostumus

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

säädökset:

Tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja. Niiden käsittelylle tarvittava erityisperuste on:

☐ yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi

☐ rekisteröidyn nimenomainen suostumus

☐ tärkeä yleinen etu koskeva syy lainsäädännön nojalla

☐ kansanterveyteen liittyvä yleinen etu

12. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?

Haastateltavat viittaavat aineistossa toisiinsa etunimillä ja työnimikkeillä. Myös ammatit ja työpaikat ovat esillä.

13. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä:

☒ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta

- ☒ Haastattelu
- ☐ Videointi
- ☐ Sähköinen kyselylomake (Webropol, Redcap tai vastaava)
- ☐ Postissa lähetettävä kyselylomake
- ☐ Muu tapa, mikä:

☐ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:

☒ Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista

14. Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Ei siirretä eikä luovuteta.

15. Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä eikä luovuteta

16. Automatisoitu päätöksenteko

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

17. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi:

☐ Kyllä
Puoltavan lausunnon antanut tutkimuseettinen toimikunta:
☒ Ei

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☐ käytön rekisteröinnillä ☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)
☐ muu tapa, mikä:

Pseudonymisointi ja anonymisointi:
Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista. Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Erityistapauksissa esim., kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua ilmaista tekijät.
Tässä tutkimuksessa:
☐ Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja)
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisointi)
☐ Tunnisteellisuuteen voi palata koodiavaimen avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja
☒ Aineisto analysoidaan käyttäen vain epäsuoria tunnistetietoja
☐ Aineisto sisältää vain epäsuoria tai pseudonyymejä tunnistetietoja
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

Suojatoimet arkaluonteisten tietojen osalta:
☒ Tutkimussuunnitelma
☒ Tutkimuksen vastuuhenkilö, kuka:
☒ Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tutkimustarkoituksiin ja toimitaan siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille
☐ Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

18. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
- saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta
- tarkastaa itseään koskevat tiedot
- oikaista tietojaan
- poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)
- rajoittaa tietojensa käsittelyä
- vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu
- pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, jos käsittelyperuste on suostumus

- peruuttaa antamansa suostumus
- henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)
- tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai tutkimuksen tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estävät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

☒ Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista tullaan todennäköisesti poikkeamaan tässä tutkimuksessa:

☐ Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (informointivelvoitteesta voi poiketa tieteellisessä tutkimuksessa tietosuoja-asetuksen art. 14 kohdan 5b perusteella, jolloin tulee tehdä tietosuojan vaikutustenarviointi sekä saattaa tutkimuksen tiedot julkisesti saataville)
☐ Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
☐ Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen
☐ Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen
☐ Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

Perustelut rekisteröidyn oikeuksista poikkeamiselle:

Seuraavat suojatoimet on toteutettu tässä tutkimuksessa, jotta tutkimukseen osallistuvan oikeuksista voidaan poiketa:

☐ Tutkimustiedote on saatettu julkisesti saataville ja tutkimuksesta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi (poikettaessa tutkittavien informoinnista)
☐ Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan
☐ Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä
☐ Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille

☐ Tutkimuksessa käsitellään ns. arkaluonteisia tietoja ja siitä on tehty vaikutustenarviointi, joka on toimitettu tietosuojavaltuutetun toimistoon ennen käsittelyn aloittamista (poikettaessa tarkastus-, oikaisu-, rajoittamis- ja vastustusoikeudesta)